

小野町高齢者保健福祉計画 第9期介護保険事業計画 (令和6年度～令和8年度)

令和6年3月

福島県 小野町

目 次

第1章 計画策定にあたって

1 計画策定の趣旨	1
2 第9期計画の基本指針	2
3 計画の位置づけと期間	3
(1) 根拠法令等	3
(2) 他計画との関係	3
(3) 計画の期間	4
4 計画の策定体制	4
(1) 協議会の設置	4
(2) 介護予防・日常生活圏域二ーズ調査等の実施	4

第2章 小野町の高齢者・介護等の状況

1 人口と世帯の状況	5
(1) 人口動態	5
(2) 高齢者のいる世帯の状況	6
2 介護予防・日常生活圏域二ーズ調査のまとめ	7
(1) 調査対象・調査方法・調査実施時期	7
(2) 介護予防・日常生活圏域二ーズ調査結果	8
(3) 在宅介護実態調査結果	15
3 小野町の介護保険事業の状況	20
(1) 要支援・要介護認定者数の推移	20
(2) 要介護度別の認定者の推移	21
(3) 介護保険サービスの利用状況	22
(4) 介護給付の状況	24
4 小野町の高齢者数等の将来推計	25
(1) 人口と高齢者数の推計	25
(2) 被保険者数の見込み	26
(3) 要支援・要介護者数の推計	27
5 第9期計画における課題の整理	28

第3章 計画の基本的考え方

1 計画の基本理念と目標	30
(1) 基本理念	30
(2) 基本目標	31
(3) 地域包括ケアシステムの全体像	32
(4) 地域共生社会の実現	33
2 計画の体系	34

第4章 施策の展開

基本目標1 介護予防と生きがいづくりの推進	35
1 健康づくりの推進	35
(1) 疾病の早期発見・治療の促進	35
(2) 疾病予防と心身の健康づくりの促進	36
(3) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施	37
(4) 地域医療の強化	38
2 介護予防・日常生活支援総合事業の推進	39

(1) 介護予防・日常生活支援サービス事業	39
(2) 一般介護予防事業	40
3 生きがいづくりと社会参加の推進	41
(1) 就労機会の拡大	41
(2) 交流機会の拡充	42
基本目標2 安全・安心な暮らしの確保	44
1 地域の支え合いの支援	44
2 包括的支援事業・任意事業の推進	45
(1) 地域包括支援センターの体制強化	45
(2) 包括的支援事業	47
(3) 任意事業	49
3 成年後見制度の利用促進	49
(1) 成年後見制度利用促進のための体制整備	49
(2) 消費者被害の防止	51
4 認知症施策の充実	52
(1) 普及啓発・本人発信支援	52
(2) 予防（早期発見・早期対応）	53
(3) 医療・ケア、介護サービス・家族介護者への支援	54
5 高齢者虐待防止対策の推進	55
(1) 高齢者虐待防止に向けた体制整備の強化	55
6 災害・感染症対応等の充実	56
(1) 地域の防災対策の推進	56
(2) 感染症対策の推進	57
7 多様な生活支援の充実	57
(1) 生活基盤の確保	58
(2) 交通利便性の向上	59
(3) 福祉サービスの充実	59
8 介護人材の確保とサービスの質の向上	61
(1) 介護人材の確保・質の向上	61
基本目標3 介護サービスの充実	63
1 自立支援・重度化防止に向けた取り組み	63
2 介護保険サービスなどの充実	65
(1) 日常生活圏域の設定	65
(2) サービスの質の向上と利用者支援の充実	65
(3) 文書負担軽減に向けた取り組み	66
3 介護サービスの見込みと保険料	67
(1) 居宅サービス/介護予防サービスの見込	67
(2) 地域密着型サービス/地域密着型介護予防サービス	71
(3) 施設サービス	73
(4) 総給付費	73
(5) 標準給付費	74
(6) 地域支援事業費	74
(7) 介護保険料の算出の流れ	75
(8) 保険料の算定	77

第5章 計画の推進

1 計画の推進体制	79
（1）計画の周知と情報提供	79
（2）連携による施策の推進	79
（3）人材確保の支援	79
2 計画の推進体制	80
（1）計画の進捗状況の点検	80
（2）点検内容	80

第1章 計画策定にあたって

1 計画策定の趣旨

社会状況の変化に伴い、高齢者の介護を社会全体で支え合うため、2000年（平成12年）創設された介護保険制度は、介護が必要な高齢者の生活の支えとして現在まで定着、発展してきました。それと同時に、わが国の総人口はさらなる減少に転じ、高齢者人口は増加、高齢化の進展も続いています。この現状から、国ではいわゆる団塊の世代すべてが75歳以上になる2025年（令和7年）を見据えて、2014年（平成26年）には、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」、2017年（平成29年）には、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」により、医療・介護・予防・住まい・生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の構築と深化・推進、及び介護保険制度の持続可能性の確保のための改革と見直しが行われてきました。

2025年（令和7年）の到来にあたり、さらにその先を展望すると、いわゆる団塊ジュニア世代が65歳以上になる2040年（令和22年）に向け、既に減少に転じている生産年齢人口の減少が加速し、高齢者人口がピークを迎えるとともに、介護ニーズの高い85歳以上人口は2035年（令和17年）頃まで顕著な増加傾向が見込まれています。これに伴った医療・介護の複合的なニーズを有する慢性疾患等の高齢者の増加から、医療・介護の連携性の確保が重要となり、人口構成や介護需要の動向、また介護資源の脆弱性など、地域の実情を踏まえた介護サービス基盤を医療提供体制と一体的に整備していくことが求められます。そのうえ、85歳以上人口の増加と高齢単独・夫婦世帯の増加に伴って、認知症もしくは認知機能が低下した高齢者の増加が見込まれており、そうした高齢者の意思決定支援や権利擁護の重要性も高まっています。このように、介護サービス需要の変化が想定される一方で、生産年齢人口の急減に直面することに際し、高齢者介護を支える人的基盤の確保及び介護現場の生産性の向上を推進していく必要があります。

小野町では、令和3年度から5年度にかけて「小野町高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画」を策定し、医療・介護・予防・住まい・生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の構築・深化に向けた取り組みを進めてきました。これまでの取り組みの方向性を引き継ぎつつ、国における制度改正や本町における中長期的な視点での高齢者の実情を踏まえた見直しを行い、高齢者福祉のさらなる充実と、持続可能で安定した介護保険事業の推進に向け、基本的な方向性と具体的な施策を明らかにすることを目的として、高齢者施策を総合的に推進していくための「小野町高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画」を策定します。

2 第9期計画の基本指針

第9期介護保険事業計画における国の基本指針のポイントは以下のとおりです。

①介護サービス基盤の計画的な整備	①地域の実情に応じたサービス基盤の整備 ●中長期的な地域の人口動態や介護ニーズの見込み等を適切に捉えて、施設・サービス種別の変更など既存施設・事業所のあり方も含め検討し、地域の実情に応じて介護サービス基盤を計画的に確保していくことが必要 ●医療・介護双方のニーズを有する高齢者の増加を踏まえ、医療・介護を効率的かつ効果的に提供する体制の確保、医療・介護の連携強化が重要 ●中長期的なサービス需要の見込みをサービス提供事業者を含め、地域の関係者と共有し、サービス基盤の整備の在り方を議論することが重要 ②在宅サービスの充実 ●居宅要介護者の在宅生活を支えるための定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護など地域密着型サービスの更なる普及 ●居宅要介護者の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、複合的な在宅サービスの整備を推進することが重要 ●居宅要介護者を支えるための、訪問リハビリテーション等や介護老人保健施設による在宅療養支援の充実
②地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取り組み	①地域共生社会の実現 ●地域包括ケアシステムは地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となり得るものであり、制度・分野の枠や「支える側」「支えられる側」という関係を超えて、地域住民や多様な主体による介護予防や日常生活支援の取り組みを促進する観点から、総合事業の充実を推進 ●地域包括支援センターの業務負担軽減と質の確保、体制整備を図るとともに、重層的支援体制整備事業において属性や世代を問わない包括的な相談支援等を担うことも期待 ●認知症に関する正しい知識の普及啓発により、認知症への社会の理解を深めることが重要 ②デジタル技術を活用し、介護事業所間、医療・介護間での連携を円滑に進めるための医療・介護情報基盤を整備 ③保険者機能の強化 ●給付適正化事業の取り組みの重点化・内容の充実・見える化
③地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性向上	●介護人材を確保するため、処遇の改善、人材育成への支援、職場環境の改善による離職防止、外国人材の受入環境整備などの取り組みを総合的に実施 ●都道府県主導の下で生産性向上に資する様々な支援・施策を総合的に推進。介護の経営の協働化・大規模化により、人材や資源を有効に活用。 ●介護サービス事業者の財務状況等の見える化を推進

3 計画の位置づけと期間

(1) 根拠法令等

本計画は、介護保険法（平成9年法律第123号）第117条に基づく「介護保険事業計画」であり、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の8に基づく「高齢者福祉計画」を一体的に策定するものです。

介護保険事業計画

介護保険のサービスの見込量と提供体制の確保と事業実施について定める計画であり、介護保険料の算定基礎ともなります。さらに、要介護状態になる前の高齢者も対象とし、介護予防事業、高齢者の自立した日常生活を支援するための体制整備、在宅医療と介護の連携、住まいの確保などについて定める計画です。

高齢者福祉計画

地域における高齢者を対象とする福祉サービス全般の供給体制の確保に関する計画です。

(2) 他計画との関係

本計画は、本町のまちづくりの基本計画である「小野町総合計画」の部門別計画として位置づけ、国、県の指針や計画、町の関係計画などとの整合性を図ります。

さらに、高齢者支援において欠くことのできない施策分野である「後期高齢者医療制度」「健康増進法」などを根拠とした高齢者保健分野の施策について関わりのある諸計画との調和を図るものです。

(3) 計画の期間

計画期間は、令和6年度から令和8年度の3か年となりますが、団塊の世代（昭和22年から昭和24年生まれの方）が75歳以上となる令和7年度、団塊ジュニア世代が65歳になる令和22年度を見据えた中長期的な目標を掲げた計画となります。

●計画の期間



4 計画の策定体制

高齢者に対する福祉施策や介護サービスのあり方については、高齢者はもとより広く住民のニーズを把握し、それを反映させるよう配慮する必要があります。そこで、本計画の見直しに際し、以下のような取り組みを行いました。

(1) 協議会の設置

本計画の策定にあたり、「小野町高齢者福祉サービス推進協議会」を設置し、保健・医療・福祉の関係者のほか、学識経験者、地域団体の代表、一般住民など多様な立場の方々に委員として参画を求め、計画内容を総合的にご審議いただきました。

(2) 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査等の実施

「第9期介護保険事業計画（令和6年度～令和8年度）」を策定するにあたり、日常生活の状況、健康状態、福祉・介護保険事業に関する意見などを伺い、策定の基礎資料さらには今後の保健福祉行政に活かすために、2種類（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査・在宅介護実態調査）のアンケート調査を実施しました。

第2章 小野町の高齢者・介護等の状況

1 人口と世帯の状況

(1) 人口動態

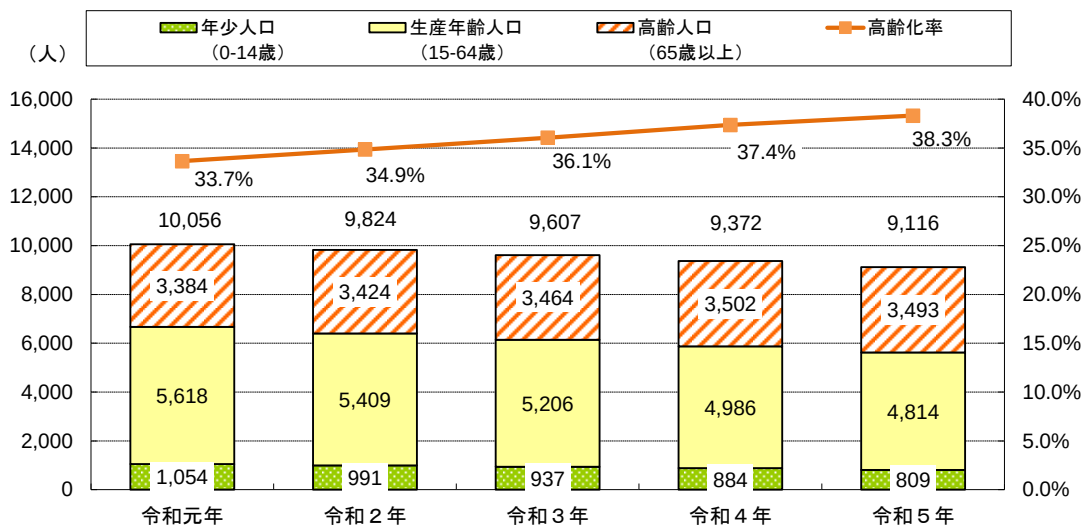
①人口推移と年齢3区分人口構成比

令和元年以降の人口推移をみると、総人口は減少傾向で推移しています。

人口推移を年齢3区分でみると、高齢人口は令和4年までは増加傾向で推移していますが令和5年で減少に転じています。年少人口、生産年齢人口は減少傾向で推移しています。

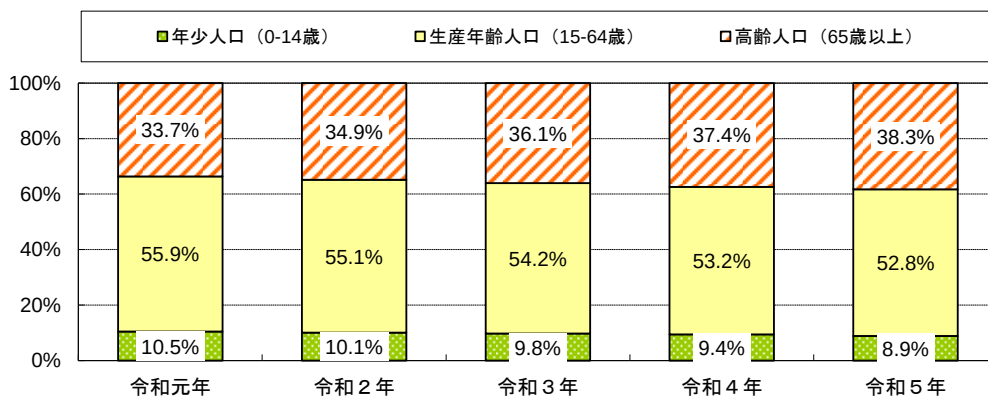
令和5年の総人口 9,116 人、高齢化率は 38.3%となっています。

■小野町の年齢3区分人口推移



資料：住民基本台帳（各年9月末現在）

■小野町の年齢3区分人口構成比



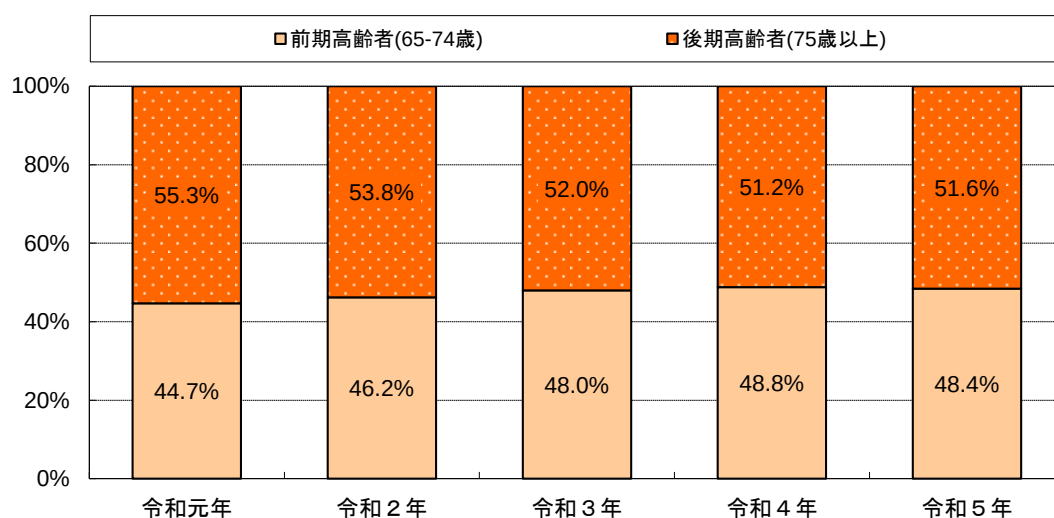
資料：住民基本台帳（各年9月末現在）

②前期・後期高齢者比率

本町の高齢者比率を、65歳以上75歳未満の前期高齢者、75歳以上の後期高齢者の区分で推移をみると、いずれの年も5割以上を後期高齢者が占めています。

令和5年の前期高齢者比率は48.4%、後期高齢者比率は51.6%となっています。

■小野町の前期・後期高齢者比率の推移



資料：住民基本台帳（各年9月末現在）

（2）高齢者のいる世帯の状況

国勢調査から本町の世帯数の推移をみると、全世帯数は平成22年から100世帯減少しています。

高齢者のいる世帯の割合は増加しており、高齢者単身世帯と高齢夫婦世帯の世帯数は増加しています。

	平成22年	平成27年	令和2年
全世帯数	3,491世帯	3,420世帯	3,391世帯
65歳以上の親族のいる世帯	2,123世帯	2,105世帯	2,119世帯
(対全世帯数比)	60.8%	61.5%	62.5%
高齢者単身世帯	316世帯	241世帯	427世帯
(対全世帯数比)	9.1%	7.0%	12.6%
高齢夫婦世帯	270世帯	301世帯	348世帯
(対全世帯数比)	7.7%	8.8%	10.3%

※高齢夫婦世帯とは、夫65歳以上妻60歳以上の1組の一般世帯

資料：国勢調査

2 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査のまとめ

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（令和4年度）、在宅介護実態調査（令和5年度）を実施した調査結果を抜粋して掲載します。

（1）調査対象・調査方法・調査実施時期

①調査対象

調査票種別	対象者	配布数	回収数	回収率
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査	要介護1～5の認定を受けていない65歳以上の方	2,941件	2,285件	77.7%
在宅介護実態調査	要支援・要介護認定を受け在宅で生活している方	500件	340件	68.0%

②調査方法

郵送による配布・回収

③調査の実施時期

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査：令和4年12月～2月

在宅介護実態調査：令和5年9月～10月

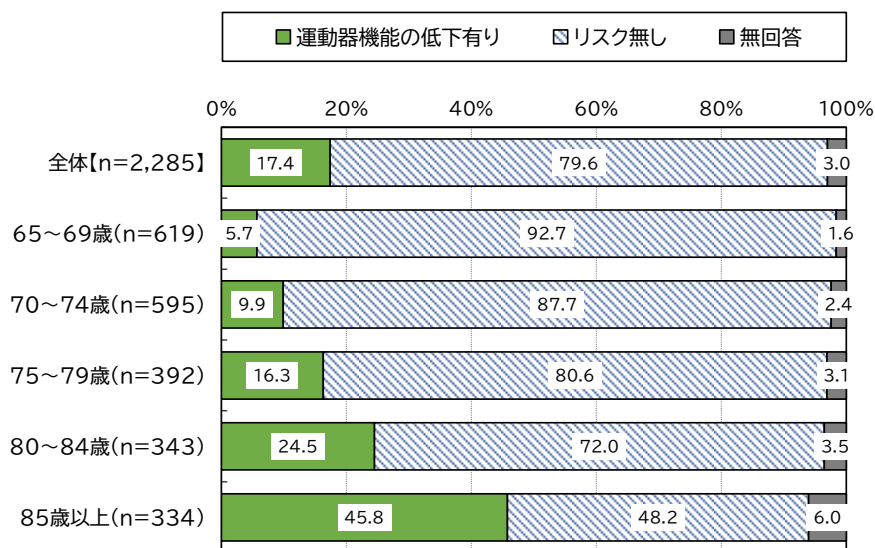
(2) 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果

①運動器の機能低下について

運動器の機能低下状況は、全体の17.4%が該当者となっています。

年齢別では、年齢が上がるにつれて該当者が多くなる傾向となっており、85歳以上の45.8%が該当者となっています。

■年齢別 運動器の機能低下状況

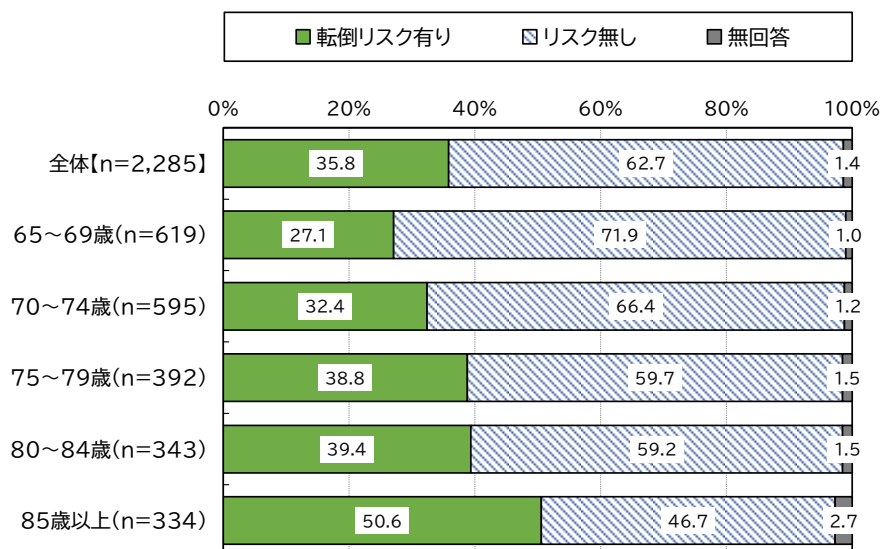


②転倒リスクについて

転倒リスク状況は、全体の35.8%が該当者となっています。

年齢別では、年齢が上がるにつれて該当者が多くなる傾向となっており、85歳以上の50.6%が該当者となっています。

■年齢別 転倒リスク状況

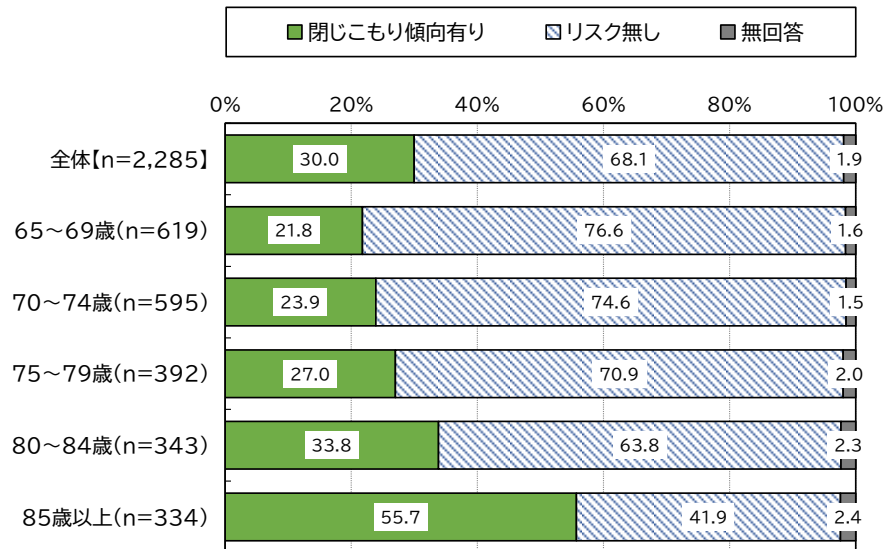


③閉じこもり傾向について

閉じこもり傾向は、全体の30.0%が該当者となっています。

年齢別では、年齢が上がるにつれて該当者が多くなる傾向となっており、85歳以上の55.7%が該当者となっています。

■年齢別 閉じこもり傾向

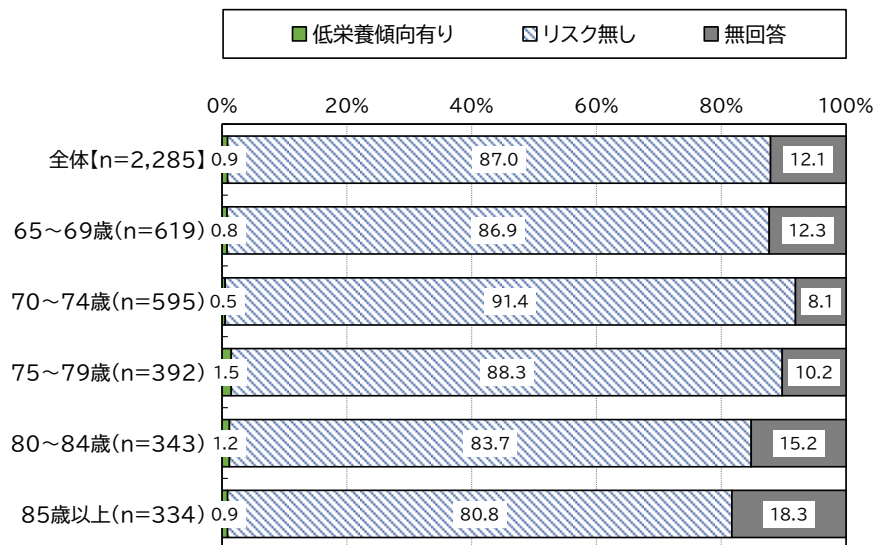


④低栄養傾向について

低栄養傾向の状況は、全体の0.9%が該当者となっています。

年齢別では、75～79歳の1.5%が該当者となっています。

■年齢別 低栄養傾向の状況

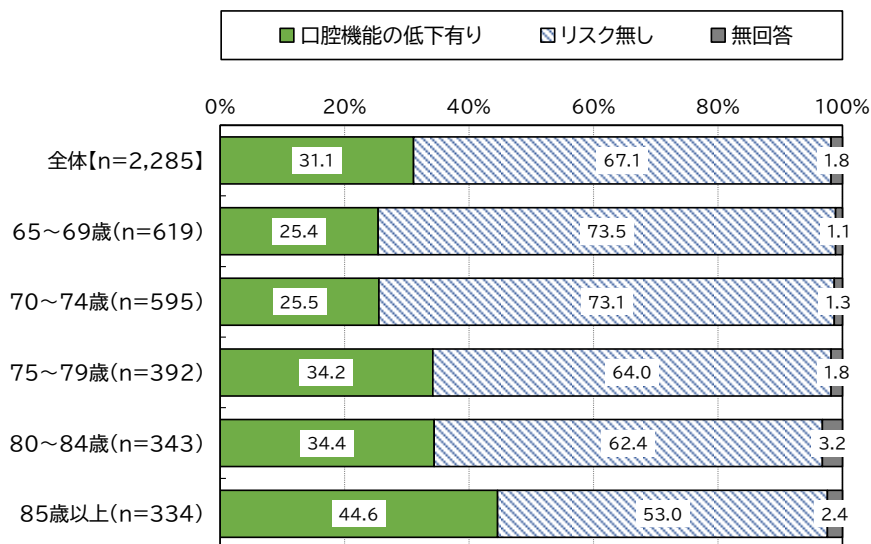


⑤口腔機能の低下について

口腔機能の低下状況は、全体の31.1%が該当者となっています。

年齢別では、年齢が上がるにつれて該当者が多くなる傾向となっており、85歳以上の44.6%が該当者となっています。

■年齢別 口腔機能の低下状況

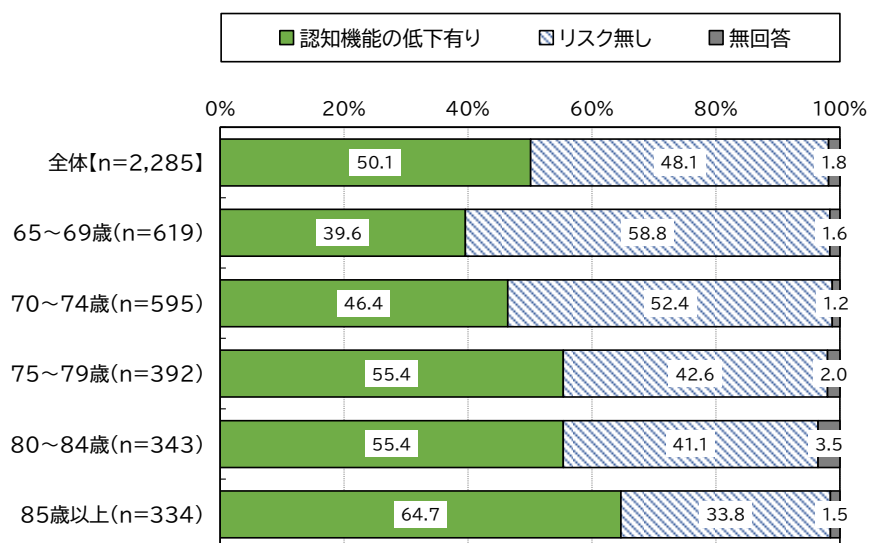


⑥認知機能の低下について

認知機能の低下状況は、全体の50.1%が該当者となっています。

年齢別では、年齢が上がるにつれて該当者が多くなる傾向となっており、85歳以上の64.7%が該当者となっています。

■年齢別 認知機能の低下状況



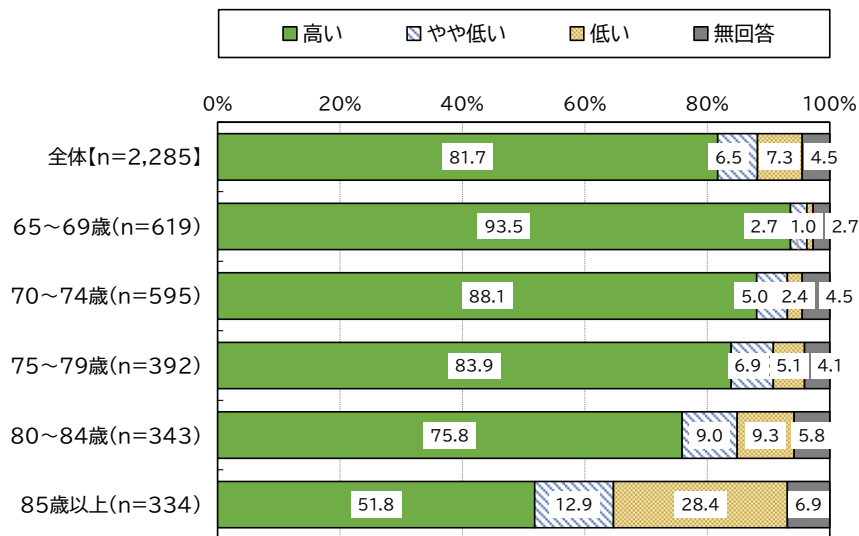
⑦ IADL（手段的日常生活動作）の低下について

IADLの低下は、「やや低い」、「低い」を低下者とする、全体の13.8%が該当者となっています。

年齢別では、年齢が上がるにつれて該当者が多くなる傾向にあり、85歳以上の41.3%が該当者となっています。

※IADL：ADL(日常生活動作)に関連した、買い物・料理・掃除等の幅広い動作が可能な能力のこと

■年齢別 IADLの低下状況

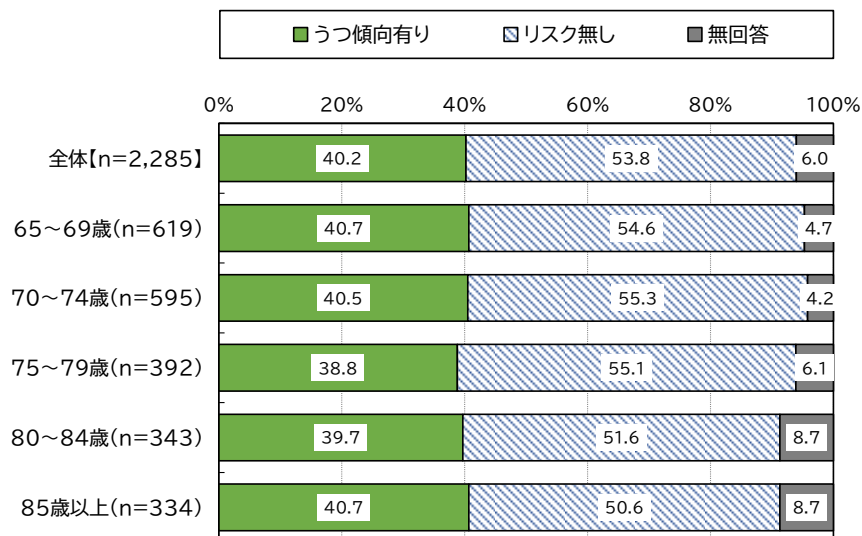


⑧ うつ傾向について

うつ傾向は、全体の40.2%が該当者となっています。

年齢別では、全ての年代で約4割の人が該当者となっています。

■年齢別 うつ傾向



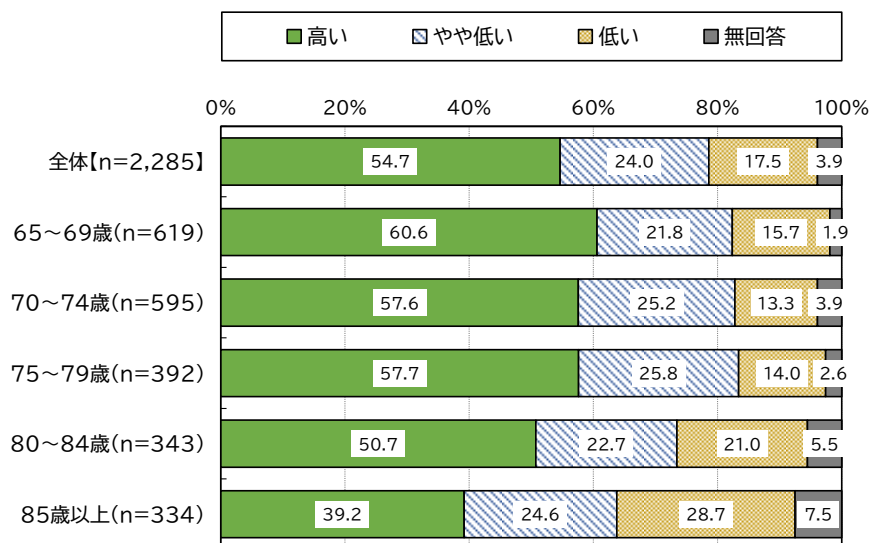
⑨知的能動性の低下

知的能動性の低下は、「やや低い」、「低い」を低下者とする、全体の41.5%が該当者となっています。

年齢別では、年齢が上がるにつれて該当者が多くなる傾向にあり、85歳以上の53.3%が該当者となっています。

※知的能動性：探索、創作、余暇活動などの知的な活動をする事

■年齢別 知的能動性の低下

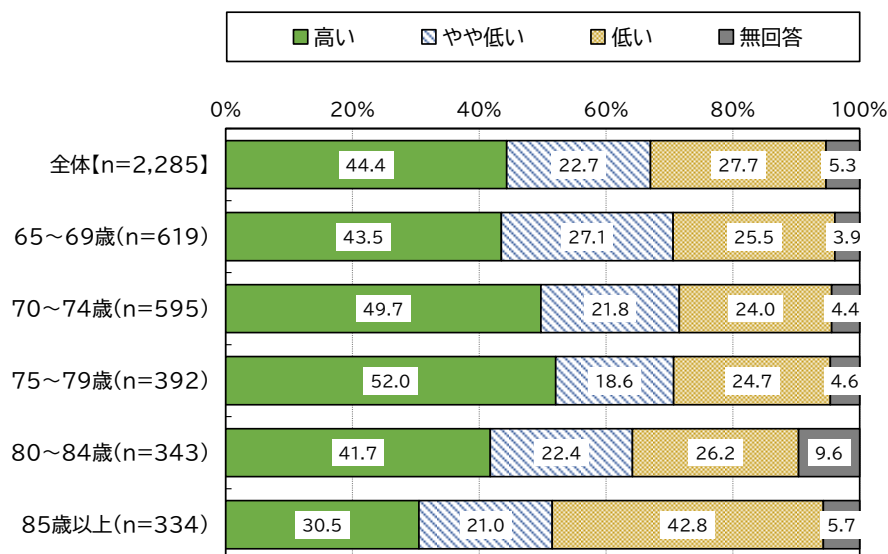


⑩社会的役割の低下

社会的役割の低下は、「やや低い」、「低い」を低下者とする、全体の50.4%が該当者となっています。

年齢別では、85歳以上が最も多くの63.8%が該当者となっています。

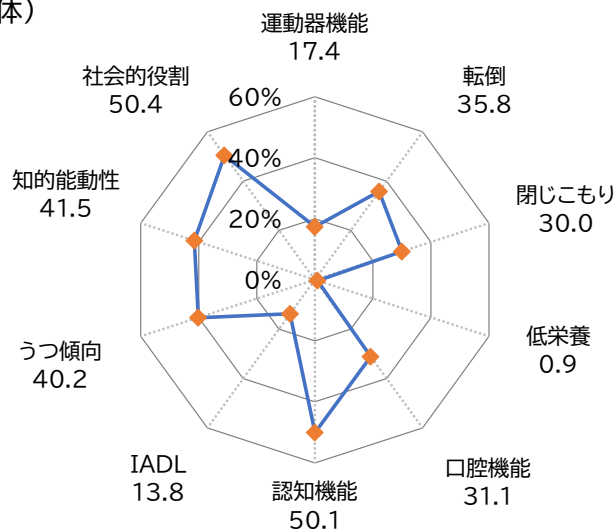
■年齢別 社会的役割の低下



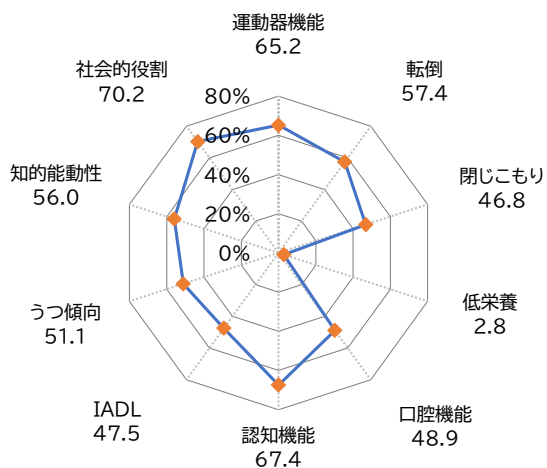
【リスク判定分析】

- ・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の回答をもとに、要介護状態になるリスク(運動機能低下リスク、転倒リスク、閉じこもり傾向、低栄養傾向、口腔機能低下リスク、認知機能低下リスク、IADL 低下、うつ傾向、知的能動性、社会的役割)について判定を行った結果、特に認知機能低下リスク該当者、社会的役割の低下リスク該当者が多い傾向となっています。
- ・リスク該当者を要支援(1・2)認定者と、認定を受けていない高齢者で見ると、低栄養以外の項目で要支援認定者のリスク該当者が多くっており、特に、社会的役割、認知機能、運動器機能の項目はリスク該当者が6割を超えています。
- ・サービスの提供が必要な高齢者に対して、個人の状態やリスクに応じたきめ細やかな対応を実施していくとともに、将来的に認知症となるリスクのある方に対して、認知症対策を重点的に実施していくこと、地域活動や交流機会の増加を図り、高齢者の孤立防止、生きがいを進めていくことも重要であると考えられます。

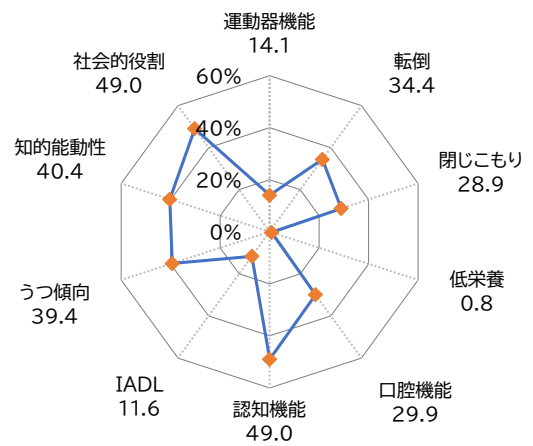
■リスク該当者割合(町全体)



■リスク該当者割合(要支援1・2認定者)



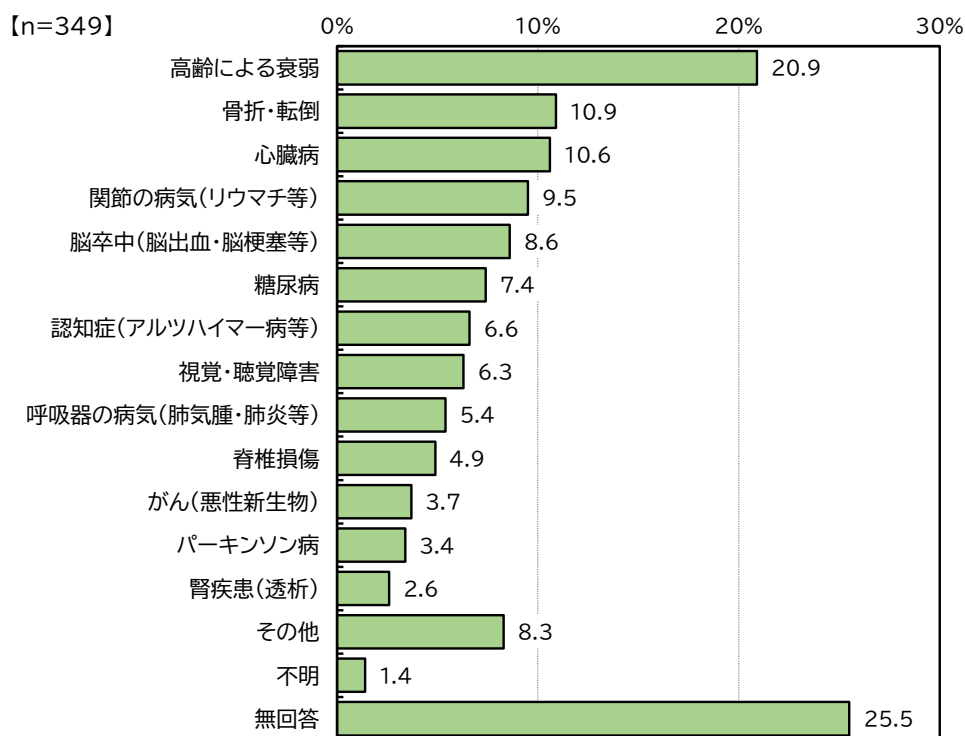
■リスク該当者割合(一般高齢者)



⑪介護・介助が必要になった主な原因

介護・介助が必要になった原因は、「高齢による衰弱」が20.9%で最も多く、次いで「骨折・転倒」(10.9%)、「心臓病」(10.6%)、「関節の病気(リウマチ等)」(9.5%)、「脳卒中(脳出血・脳梗塞等)」(8.6%)と続いています。

■介護・介助が必要になった原因

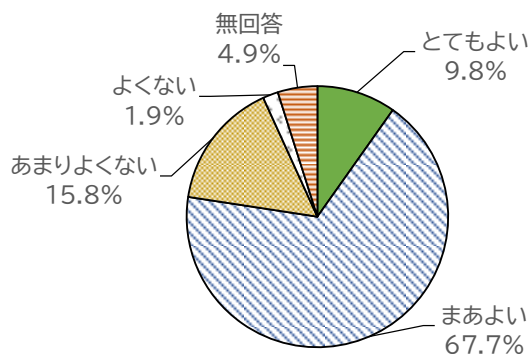


⑫現在の健康状態

現在の健康状態は、「とてもよい」(9.8%)、「まあよい」(67.7%)を合わせると、77.5%が健康状態はよいと回答している。また、「よくない」(1.9%)、「あまりよくない」(15.8%)を合わせると、17.7%が健康状態はよくないと回答しています。

■現在の健康状態

【n=2,285】



(3) 在宅介護実態調査結果

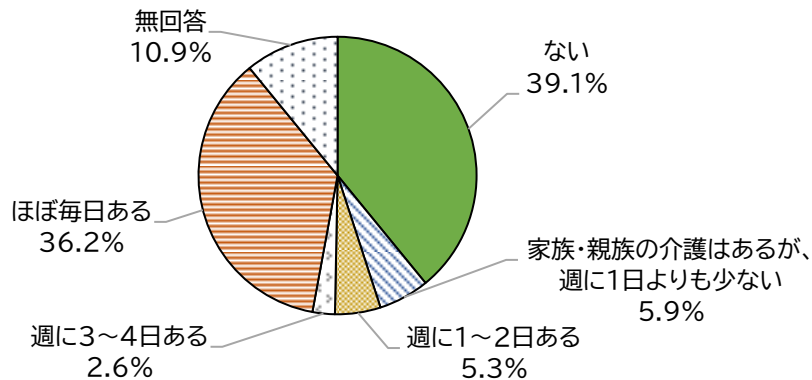
①家族からの介護の状況

ご家族やご親族の方からの介護は週にどのくらいあるかについては、「家族・親族の介護はあるが、週に1日より少ない」が5.9%、「週に1～2日ある」が5.3%、「週に3～4日ある」が2.6%、「ほぼ毎日ある」が36.2%となっています。

また、39.1%は「ない」と回答しています。

■家族や親族の方からの介護について

【n=340】

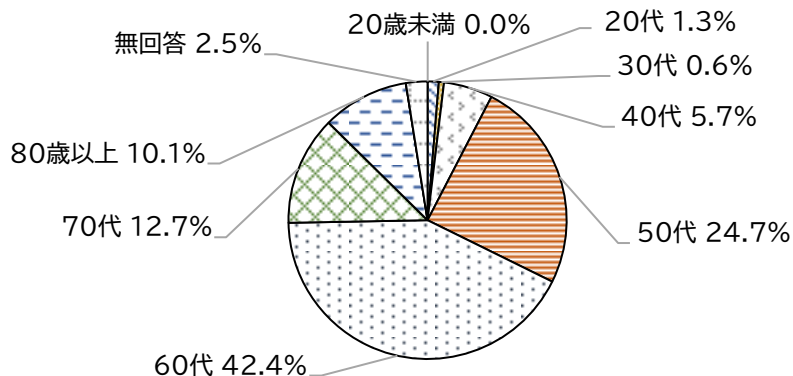


②主な介護者の年齢

主な介護者の年齢は、「60代」が42.4%と最も多く、次いで「50代」(24.7%)、「70代」(12.7%)、「80歳以上」(10.1%)、「40代」(5.7%)と続いています。

■主な介護者の年齢

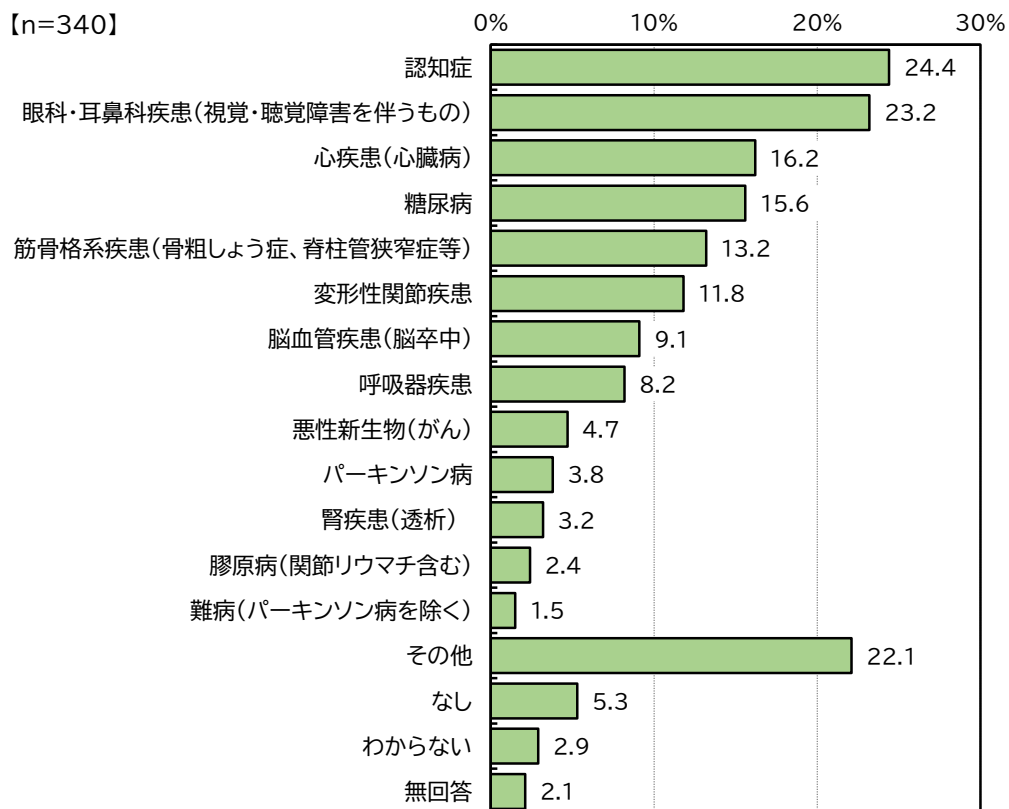
【n=158】



③現在抱えている傷病

「認知症」が24.4%と最も多く、次いで「眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの）」(23.2%)、「その他」(22.1%)、「心疾患（心臓病）」(16.2%)、「糖尿病」(15.6%)と続いています。

■現在抱えている傷病

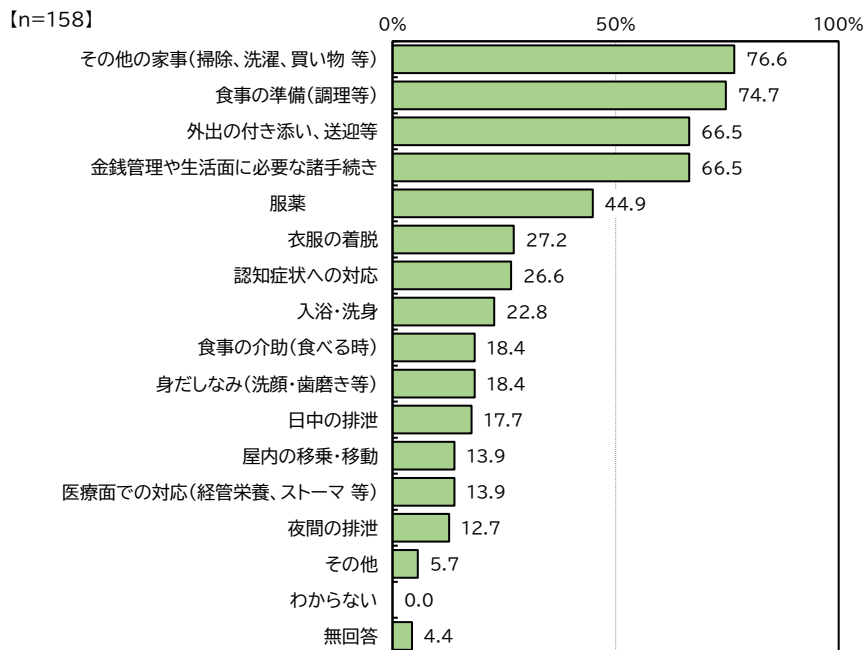


④家族や親族が行っている介護と不安に感じる介護

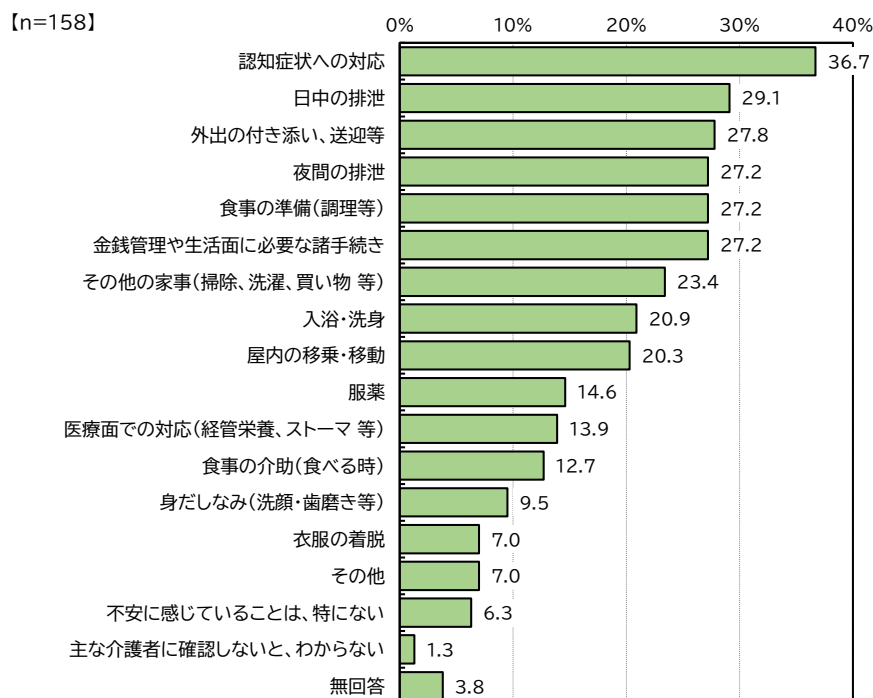
現在行っている介護は、「その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）」、「食事の準備（調理等）」、「外出の付き添い、送迎等」、「金銭管理や生活面に必要な諸手続き」などが多くなっています。

不安に感じる介護は、「認知症状への対応」、「日中の排泄」、「外出の付き添い、送迎等」、「夜間の排泄」、「食事の準備（調理等）」、「金銭管理や生活面に必要な手続き」、が比較的多くなっています。

■現在行っている介護



■不安に感じる介護

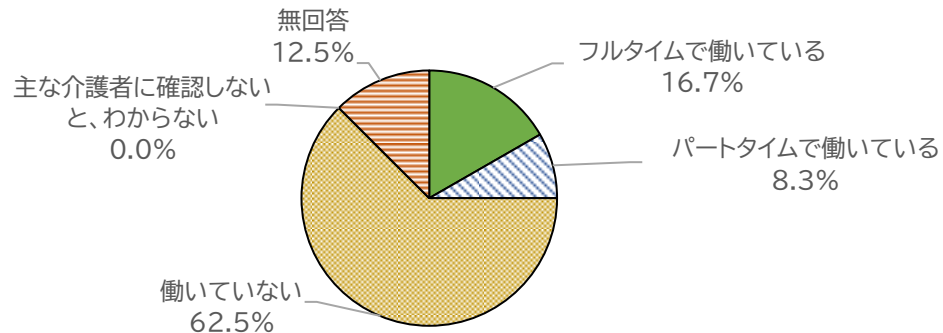


⑤主な介護者の勤務形態

主な介護者の勤務形態は、「フルタイムで働いている」と「パートタイムで働いている」を合わせた25.0%が就労している状況です。

■主な介護者の勤務形態

【n=24】



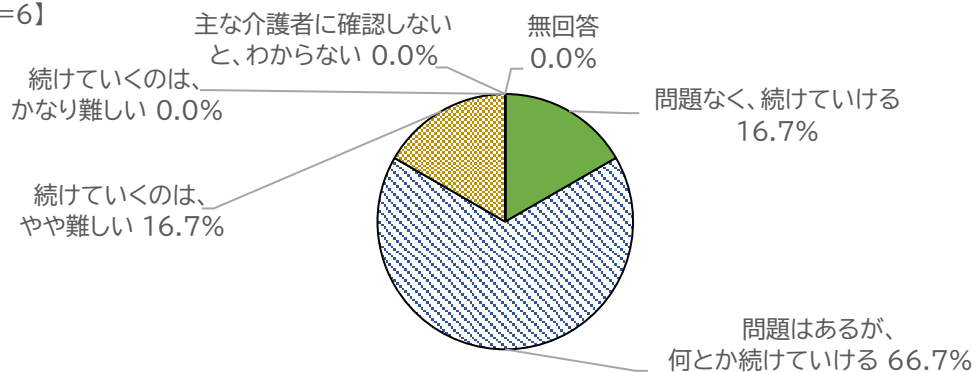
⑥仕事と介護の継続

仕事と介護の継続については、「問題はあるが、何とか続けていける」が66.7%と最も多く、「問題なく、続けていける」(16.7%)と合わせた約8割は『続けていける』と回答しています。

一方で、16.7%は「続けていくのは、やや難しい」と回答しています。

■仕事と介護の継続について

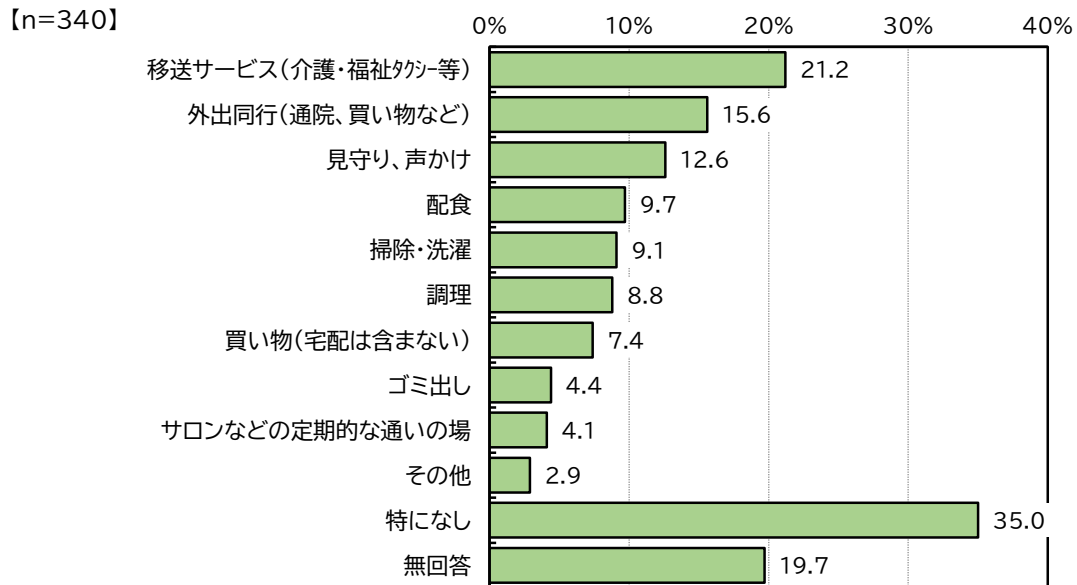
【n=6】



⑦今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス

今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービスは、「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」が21.2%と最も多くなっており、次いで「外出同行（通院、買い物など）」（15.6%）、「見守り、声かけ」（12.6%）、「配食」（9.7%）と続いています。

■日々の暮らしで心配なこと



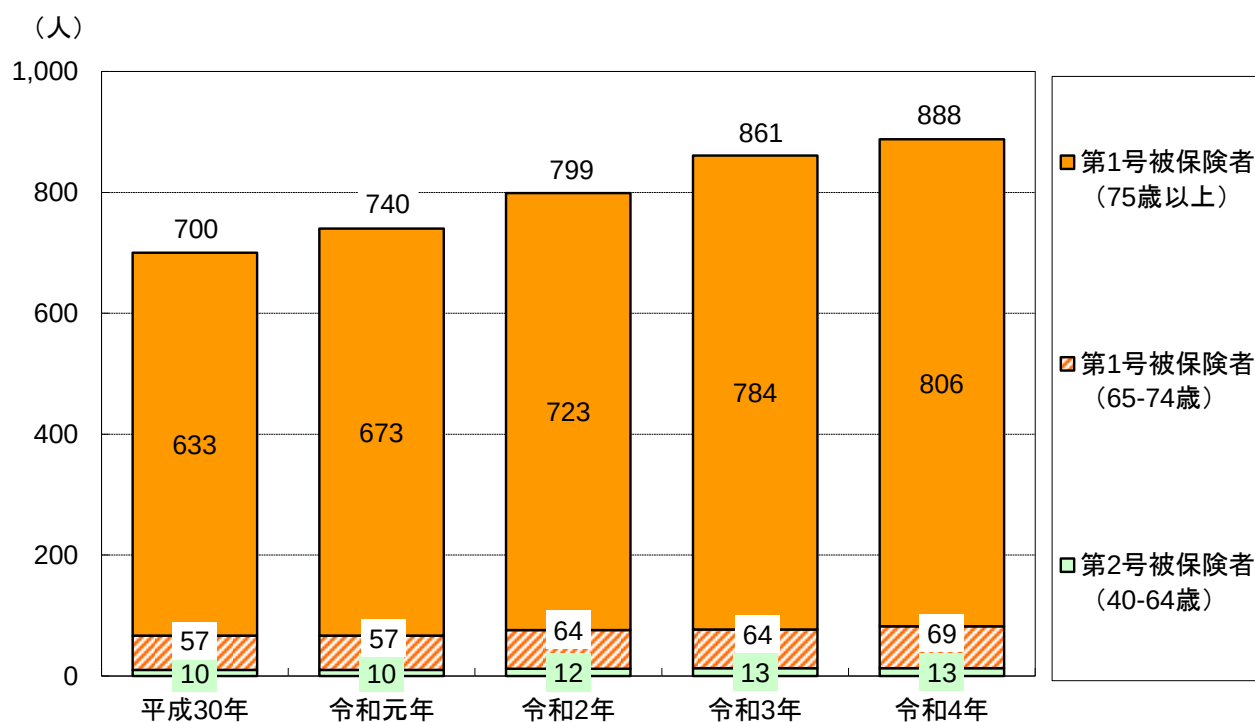
3 小野町の介護保険事業の状況

(1) 要支援・要介護認定者数の推移

本町の要支援・要介護認定者数は、増加傾向で推移しており、令和4年では888人となっています。

被保険者種類及び年齢別に認定者数をみると、第1号被保険者の75歳以上の方が大半を占めています。

■要支援・要介護認定者数の推移（被保険者種類別）



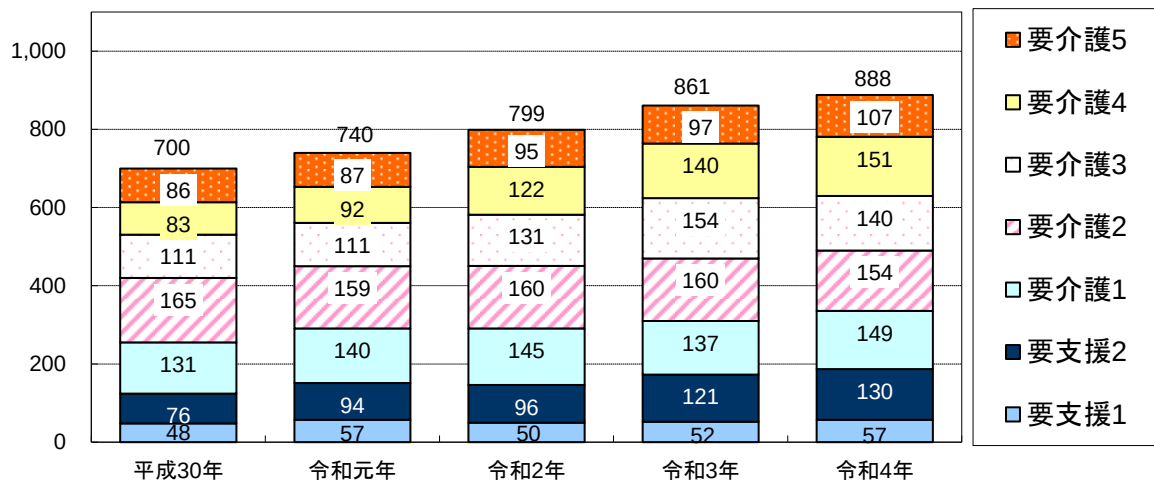
資料：介護保険事業状況報告書（各年9月末現在）

(2) 要介護度別の認定者の推移

本町の要支援・要介護認定者数の推移を要介護度別にみると、要介護2以外、増加傾向となっています。

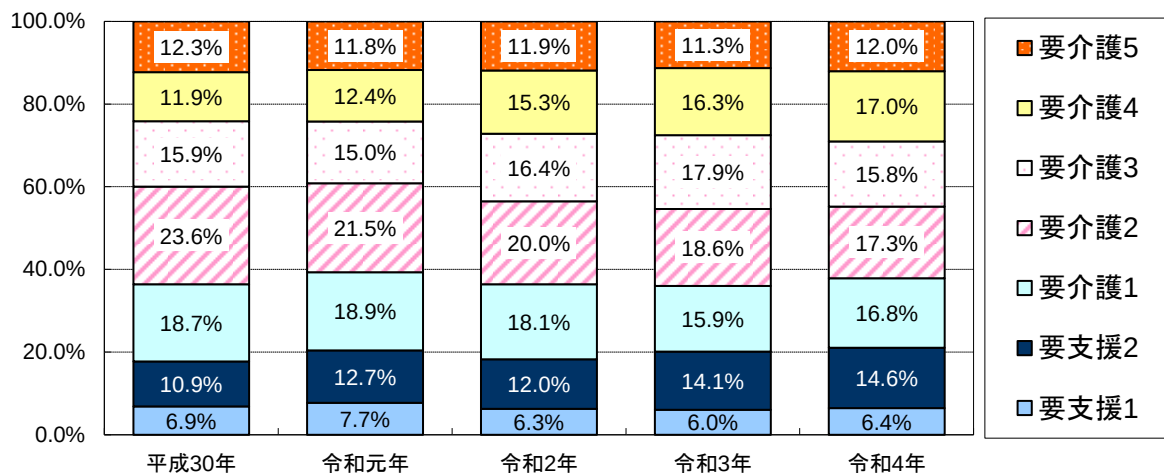
要介護度別の構成比をみると、要介護4、要介護5の重度の構成が約3割となっています。

■要支援・要介護認定者数の推移（要介護度別）



資料：介護保険事業状況報告書（各年9月末現在）

■要支援・要介護度別の認定者構成比の推移



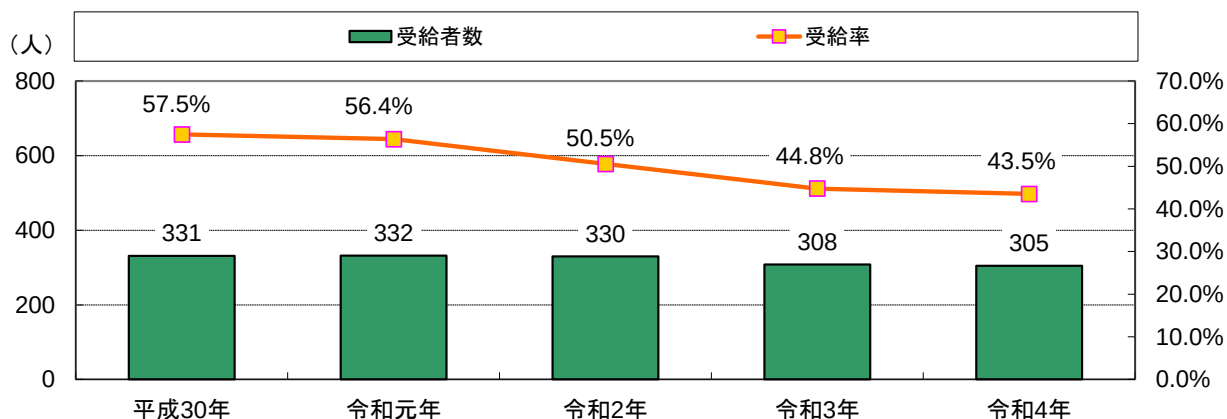
資料：介護保険事業状況報告書（各年9月末現在）

(3) 介護保険サービスの利用状況

■居宅サービス（介護給付）

要介護1～5の居宅サービスの利用状況をみると、受給者数と受給率はともに減少傾向で推移しており、令和4年の受給率は43.5%、受給者数は305人となっています。

■居宅サービス受給者数とサービス受給率の推移

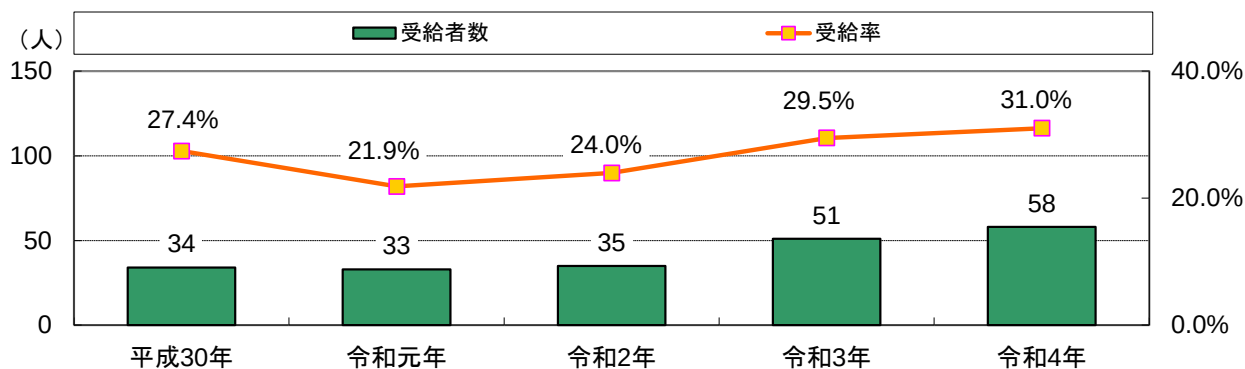


資料：介護保険事業状況報告書（各年9月末現在）

■介護予防サービス（居宅）

要支援1・2の介護予防サービスの利用状況をみると、受給者数と受給率はともに増加傾向で推移しており、令和4年の受給率は31.0%、受給者数は58人となっています。

■介護予防サービス受給者数とサービス受給率の推移

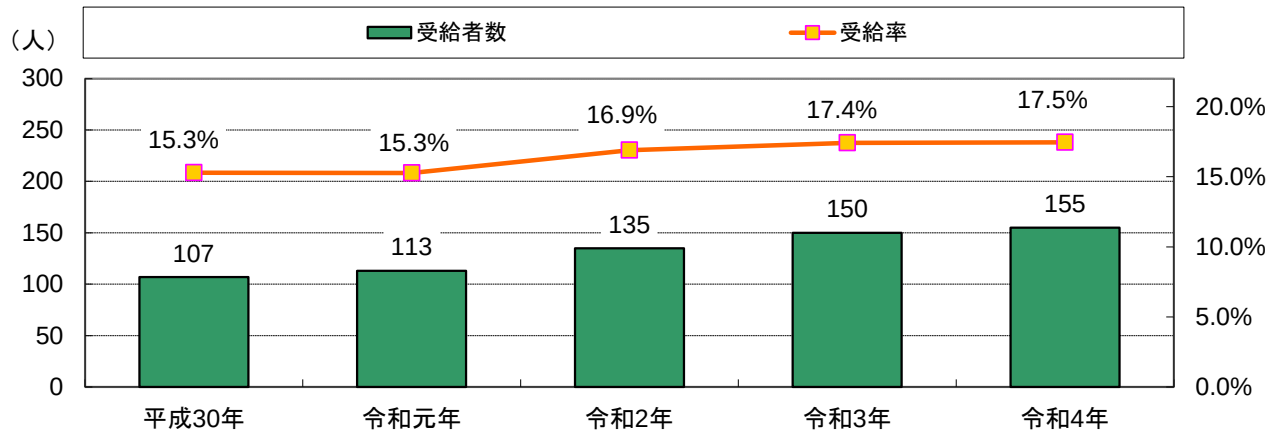


資料：介護保険事業状況報告書（各年9月末現在）

■地域密着型サービス

地域密着型サービスの利用状況をみると、受給者数、受給率ともに増加傾向で推移しており、令和4年の受給率は17.5%、受給者数は155人となっています。

■地域密着型サービス受給者数とサービス受給率の推移

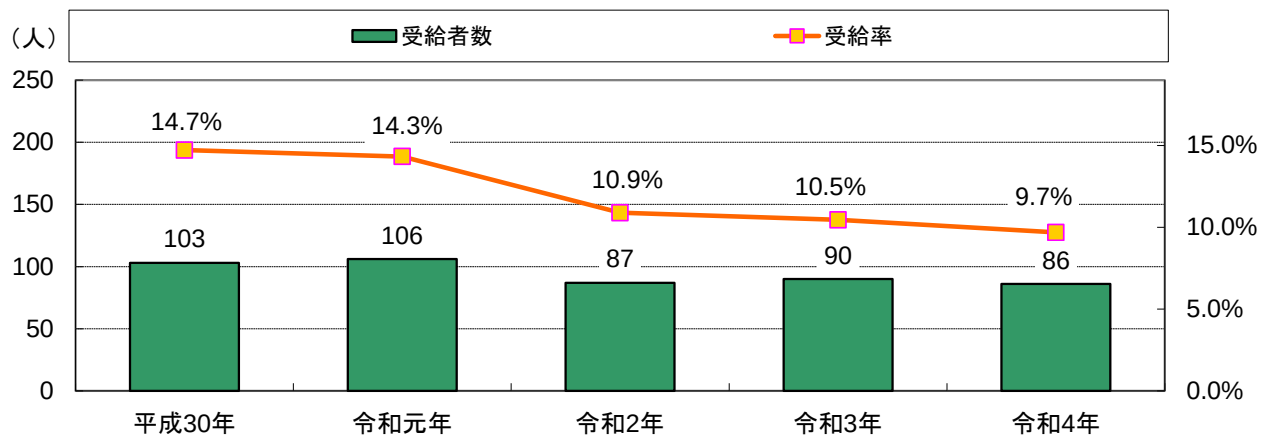


資料：介護保険事業状況報告書（各年9月末現在）

■施設サービス

施設サービスの利用状況をみると、受給者数、受給率ともに減少傾向で推移しており、令和4年の受給率は9.7%、受給者数は86人となっています。

■施設サービス受給者数とサービス受給率の推移



資料：介護保険事業状況報告書（各年9月末現在）

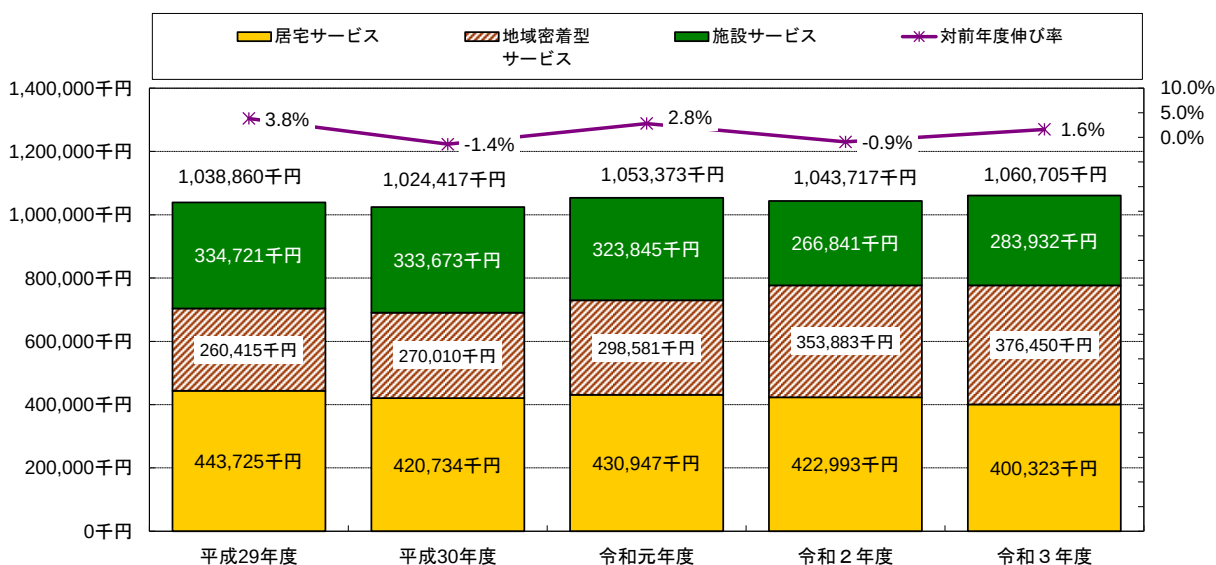
(4) 介護給付の状況

■介護保険給付費の推移

平成29年からサービス体系別に給付費の推移をみると、居宅サービス、施設サービスは減少傾向となっていますが、地域密着型サービスが増加傾向となっています。

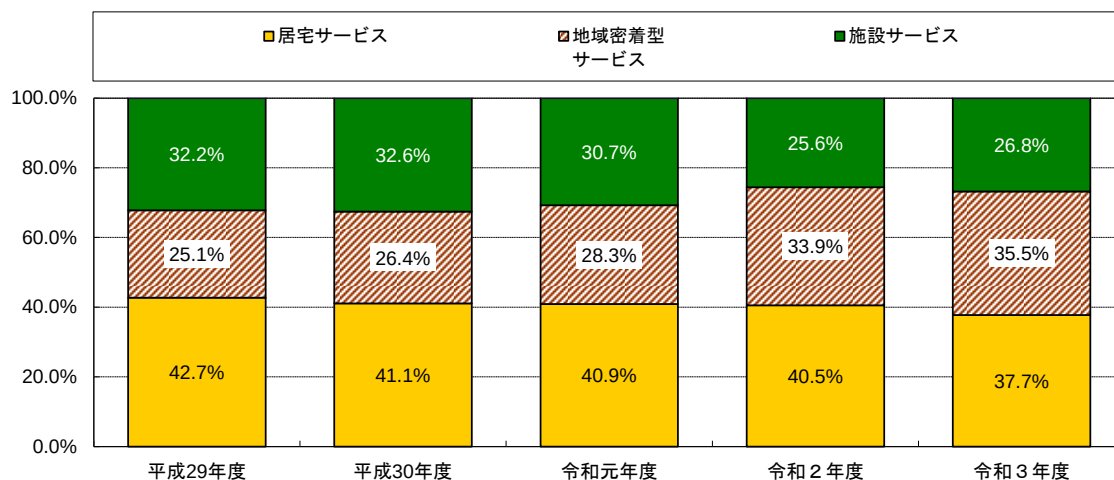
令和3年の構成比をみると、居宅サービスが37.7%、地域密着型サービスが35.5%、施設サービスが26.8%となっています。

■介護保険給付費の推移（サービス体系別）



資料：介護保険事業状況報告書（年報）

■介護保険給付費（サービス体系別）の構成比の推移



資料：介護保険事業状況報告書（年報）

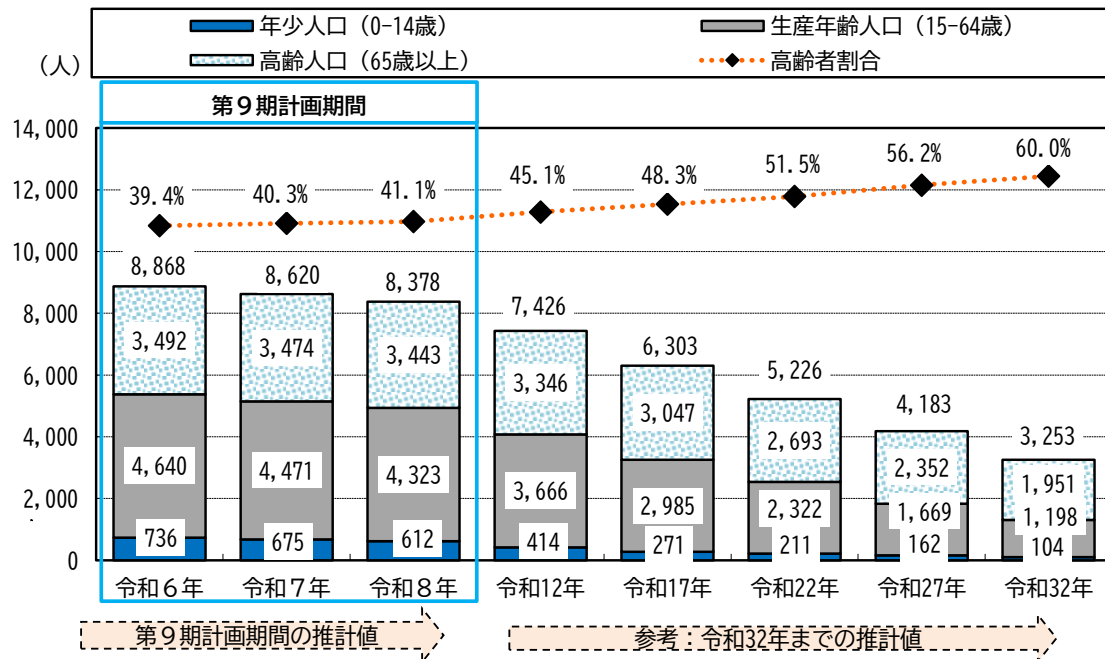
4 小野町の高齢者数等の将来推計

(1) 人口と高齢者数の推計

本町の人口推計を行った結果、推計人口は減少傾向での推移が見込まれ、第9期計画最終年の令和8年には8,378人、令和22年は5,226人となる見込みとなっています。

総人口、高齢者人口は減少傾向で推移しますが、高齢化率は増加傾向で推移する見込みです。

■小野町の推計人口



資料: 地域包括ケア「見える化」システム将来推計

■人口推計値

(単位: 人)

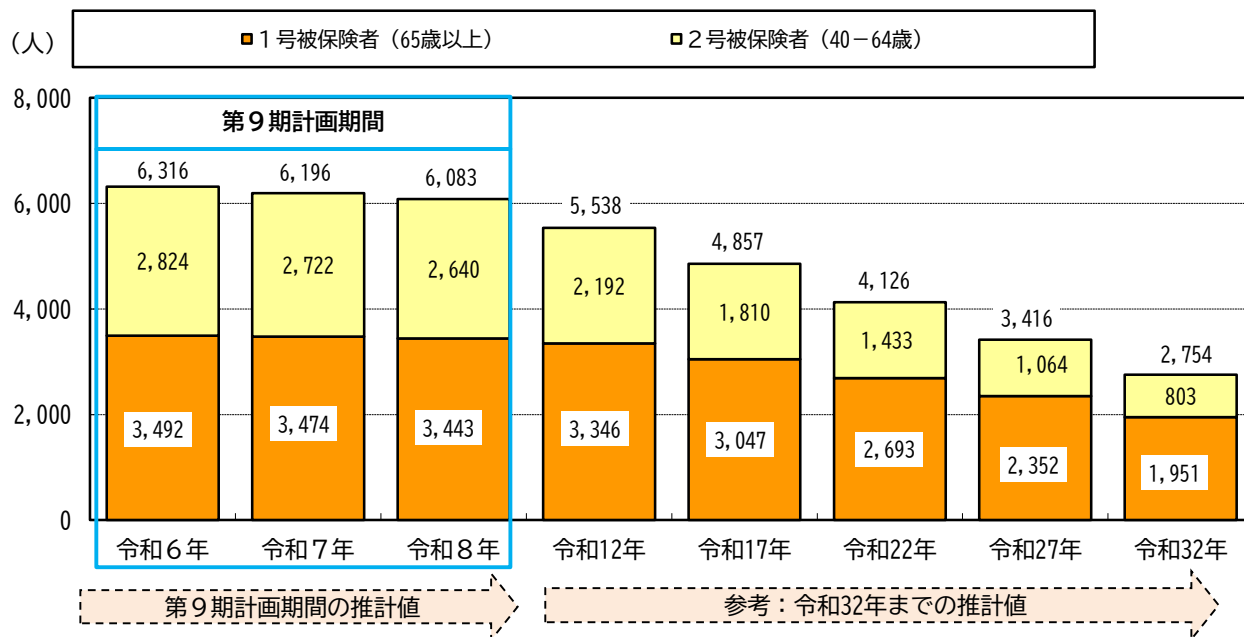
区 分	令和6年	令和7年	令和8年	令和12年	令和17年	令和22年	令和27年	令和32年
年少人口 (0-14歳)	736 8.3%	675 7.8%	612 7.3%	414 5.6%	271 4.3%	211 4.0%	162 3.9%	104 3.2%
生産年齢人口 (15-64歳)	4,640 52.3%	4,471 51.9%	4,323 51.6%	3,666 49.4%	2,985 47.4%	2,322 44.4%	1,669 39.9%	1,198 36.8%
40-64歳	2,824 31.8%	2,722 31.6%	2,640 31.5%	2,192 29.5%	1,810 28.7%	1,433 27.4%	1,064 25.4%	803 24.7%
高齢者人口 (65歳以上)	3,492 39.4%	3,474 40.3%	3,443 41.1%	3,346 45.1%	3,047 48.3%	2,693 51.5%	2,352 56.2%	1,951 60.0%
前期高齢者 (65-74歳)	1,691 19.1%	1,672 19.4%	1,633 19.5%	1,460 19.7%	1,128 17.9%	890 17.0%	811 19.4%	680 20.9%
後期高齢者 (75歳以上)	1,801 20.3%	1,802 20.9%	1,810 21.6%	1,886 25.4%	1,919 30.4%	1,803 34.5%	1,541 36.8%	1,271 39.1%
合 計	8,868	8,620	8,378	7,426	6,303	5,226	4,183	3,253

資料: 地域包括ケア「見える化」システム将来推計

(2) 被保険者数の見込み

推計人口から、計画期間中の介護保険の第1号被保険者（65歳以上）、第2号被保険者（40-64歳）の推移をみると、ともに減少傾向で推移すると見込まれ、計画期間の最終年度である令和8年には第1号被保険者が3,443人、第2号被保険者が2,640人、合計で6,083人と見込まれます。

■被保険者数の推計値



資料：地域包括ケア「見える化」システム将来推計

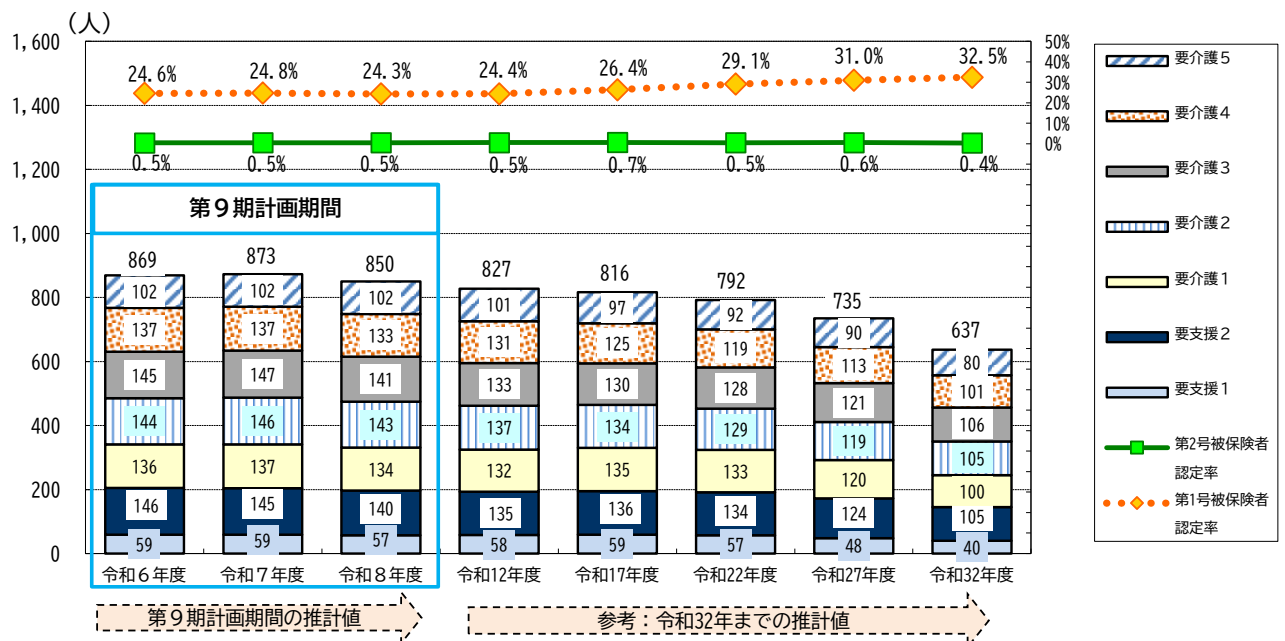
(3) 要支援・要介護者数の推計

本町の人口推計結果及び要支援・要介護認定者の認定率（出現率）の実績などから、令和6年以降の要支援・要介護認定者数を推計しました。

推計の結果、計画期間中の要支援・要介護認定者数は僅かながら減少傾向となり、令和8年には850人となる見込みです。

この認定者数が、介護保険サービスの利用量を見込む算定基礎となります。

■要介護度別認定者数の推計



資料：地域包括ケア「見える化」システム将来推計

区 分	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和12年度	令和17年度	令和22年度	令和27年度	令和32年度
要支援1	59	59	57	58	59	57	48	40
要支援2	146	145	140	135	136	134	124	105
要介護1	136	137	134	132	135	133	120	100
要介護2	144	146	143	137	134	129	119	105
要介護3	145	147	141	133	130	128	121	106
要介護4	137	137	133	131	125	119	113	101
要介護5	102	102	102	101	97	92	90	80
計	869	873	850	827	816	792	735	637
第1号被保険者認定率	24.6%	24.8%	24.3%	24.4%	26.4%	29.1%	31.0%	32.5%
第2号被保険者認定率	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.7%	0.5%	0.6%	0.4%

資料：地域包括ケア「見える化」システム将来推計

5 第9期計画における課題の整理

高齢者を取り巻く現状や将来推計、ニーズ調査結果からみた、第9期計画における課題は、以下のとおりとしました。

1 介護予防・健康づくり・生きがいづくり

アンケート調査において、転倒、閉じこもり、口腔機能、うつ傾向、認知機能のリスクについては、3割以上の方が該当者となっています。

また、介護・介助が必要になった理由では、「高齢による衰弱」、「骨折・転倒」、「心臓病」が多くなっています。

フレイル予防・介護予防に取り組むとともに高齢者の健康維持に関する取り組みや重度化防止の取り組みをそれぞれのニーズに応じて進めていく必要があります。

何歳になっても参加することができるサロン等の活動への支援や、就労機会の拡大など、地域の中で高齢者が活躍でき、多くの交流機会を増加させ、いきいきと暮らせる地域づくりを進めることも重要です。

健康づくりと介護予防の推進や地域支援事業により、地域で暮らし続けるための社会参加を促す取り組みをさらに推進していくことが求められています。

2 安全・安心な暮らしの確保

本町の人口は、年少人口（0～14歳）、生産年齢人口（15～64歳）が減少傾向となっており、人口の将来推計においても、年少人口、生産年齢人口は減少傾向で推移すると見込まれ、今後も人口に占める高齢者人口の比率は高まると予測されます。

国勢調査では、65歳以上の世帯員がいる世帯の割合は増加しており、高齢者単身世帯、高齢者夫婦の世帯数は大きく増加しています。

また、在宅介護実態調査では介護者の6割以上が60歳以上となっています。

今後、8050問題や認知症高齢者など複合的な課題を抱える人が増加することと考えられ、そのような課題を抱えた人や家族が気軽に相談することができるような体制の整備、在宅介護サービス、介護施設などニーズに合わせた多様な支援が求められています。

また、サービスや事業のみならず、地域での見守りや互助での支援が今後より一層重要度を増していくため、関係機関との連携強化も重要です。

介護者の不安に感じる介護については、「認知症への対応」が最も多くなっていることから、認知症への正しい理解と、認知症予防、早期発見への取り組み、介護家族への支援も重要です。

3 介護サービスの充実

アンケート調査において、介護者が今後も働きながら介護を続けられるかについては、“難しい”と回答した人が16.7%、「問題はあるが、何とか続けていける」と回答した方が66.7%となっており、8割以上の方が働きながらの介護の継続に何らかの問題を抱えています。仕事と介護の両立を図るためには、仕事面での支援や職場の理解に加え、介護者にかかる介護負担の軽減のための支援も必要であり、事業所などにも向けた多面的な取り組みをしていく必要があります。

介護保険サービスを必要とする高齢者が今後も増加すると見込まれる中で、高齢化の進展や高齢夫婦世帯の増加など、介護者自身の高齢化もみられることから、介護サービスに関する情報の発信やきめ細かな相談体制づくりなどにより、適切なサービスを提供するなど、介護者の心身の負担軽減に向けた取り組みが求められます。

また、介護保険事業の適正な運用と持続可能な運営を実現するために介護サービス事業者へ公正かつ適切な指導監督を行うとともに、利用者が望むサービスを選択できるよう関係機関と連携し、ニーズに即したサービスの提供に努める必要があります。

第3章 計画の基本的考え方

1 計画の基本理念と目標

(1) 基本理念

将来像に向けた町づくりに向け、高齢者福祉施策のあるべき姿として、第8期計画の考え方を引き継ぎ、本計画においても以下を基本理念に掲げます。

健康で自分らしく暮らせるまち

第8期計画では、当町における地域包括ケアシステムの深化・推進を目指し、「健康で自分らしく暮らせるまち」を基本理念として掲げました。

第9期となる本計画は、中長期的な視点に立ち、地域包括ケアシステムのさらなる深化・推進を目指し、当町で暮らす全ての人々が、生きがいを共につくり、高め合うことができる地域共生社会の実現を図るための計画であることから、第8期計画の基本理念を踏襲し、当町における高齢者福祉施策の一層の充実を推進するとともに、介護保険事業の安定した運用を図ります。

(2) 基本目標

本計画の基本理念の実現に向けて、以下3つの基本目標を施策の柱として総合的に推進します。

1 介護予防と生きがいの推進

高齢者がいつまでも元気に過ごすため、地域の人との関係性の中で自分の役割を持って生活できるよう、社会参加や交流機会の拡充を図ります。また、日々の健康づくりと心身機能の維持・改善を図る介護予防の取り組みと、高齢者がいきいきと活動でき、日々の生活を支えられて安心して暮らせる支援の取り組みが一体的に行われる体制づくりを推進します。

2 安全・安心な暮らしの確保

令和5年6月に成立した「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」に基づき、意思決定支援や権利擁護の取り組みなど、認知症の人も含めたすべての高齢者が尊厳を保ちながら地域で穏やかに暮らすことができ、家族も安心して過ごせる地域の総合的な高齢者支援システムの推進を目指すとともに、医療・介護を効率的かつ効果的に提供するために、双方の連携を強化して医療・介護基盤の強化を推進します。

また、令和5年3月に厚生労働省が改定した「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について（高齢者虐待防止マニュアル）」をもとに、高齢者虐待の未然防止、早期発見・対応に向け、関係各機関等の連携協力体制を整備します。

その他、災害時対策、感染症対策など、高齢者が安心・安全に生活できるまちづくりを推進します。

3 介護サービスの充実

今後も引き続き、介護を必要とする人が増えることが想定されることから、高齢者の状況に合わせ、居宅での生活又は施設での生活を選択できるように、サービス量の確保、質の向上を図るとともに、地域の実情に応じ、柔軟かつ効率的にサービス提供できる環境づくりを段階的に進めていきます。

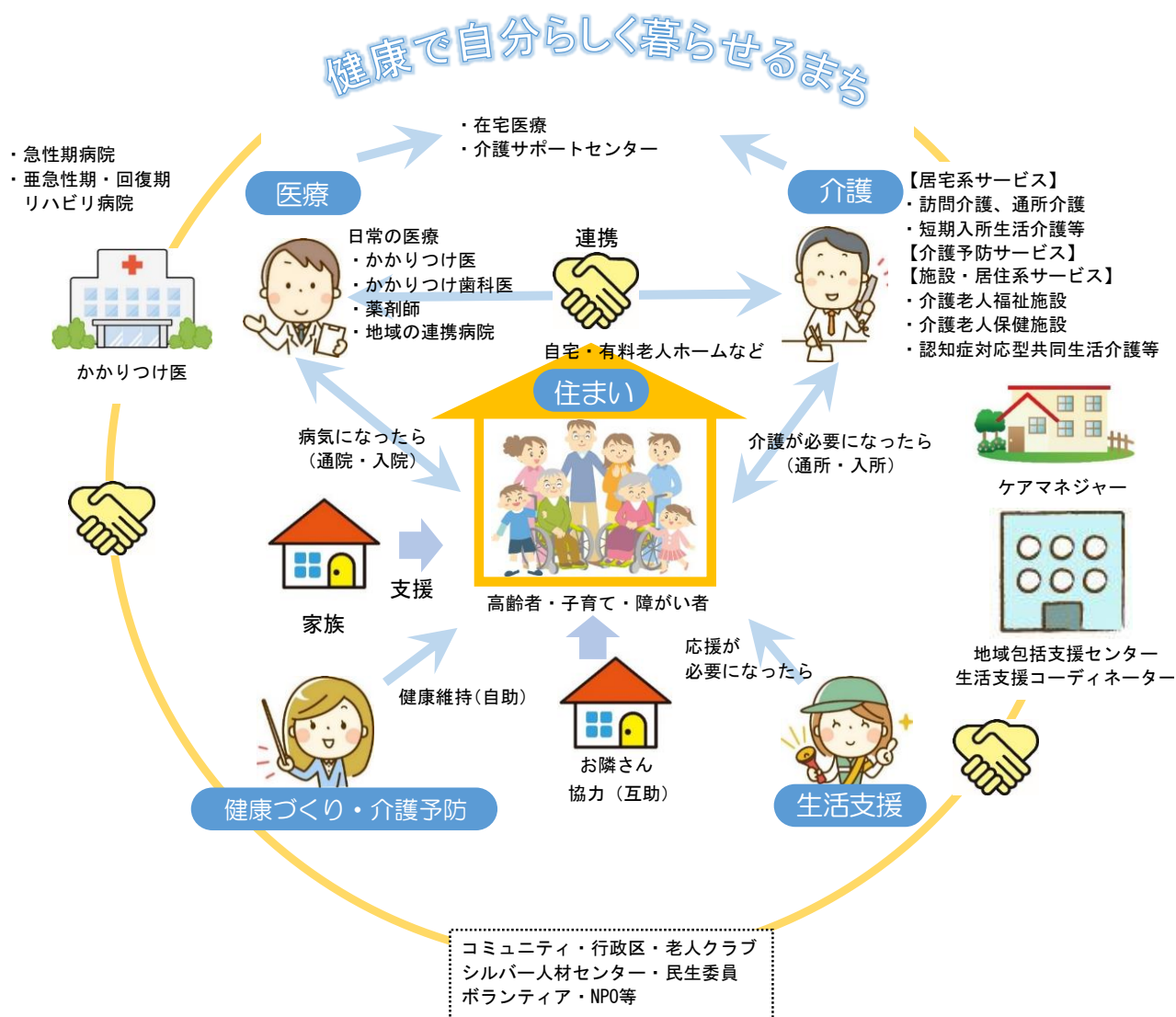
介護サービス基盤については、地域や高齢者のニーズ及び既存施設の実態等を踏まえ、医療との連携、介護予防サービスも踏まえた提供体制の整備を図り、地域におけるサービス基盤の充実を図ります。

(3) 地域包括ケアシステムの全体像

「地域包括ケアシステム」は、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていく必要があります。

健康な高齢者が、いつまでも元気で暮らすための生活支援や介護予防、介護が必要になった場合には介護保険により提供される施設・居住系あるいは在宅で受けられるサービス、もし重度の要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるように、住まい・医療・介護・予防・生活支援が各地域で一体的に提供される高齢者支援の社会的な仕組み、それが地域包括ケアシステムです。

■地域包括ケアシステムのイメージ



（４）地域共生社会の実現

地域共生社会は、制度・分野ごとの縦割りや「支え手」・「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人一人の暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会の実現のため、町民と行政が協働し、地域や個人が抱える地域生活課題を解決していけるよう、様々な相談を受け止める包括的な支援体制を整備することも求められています。

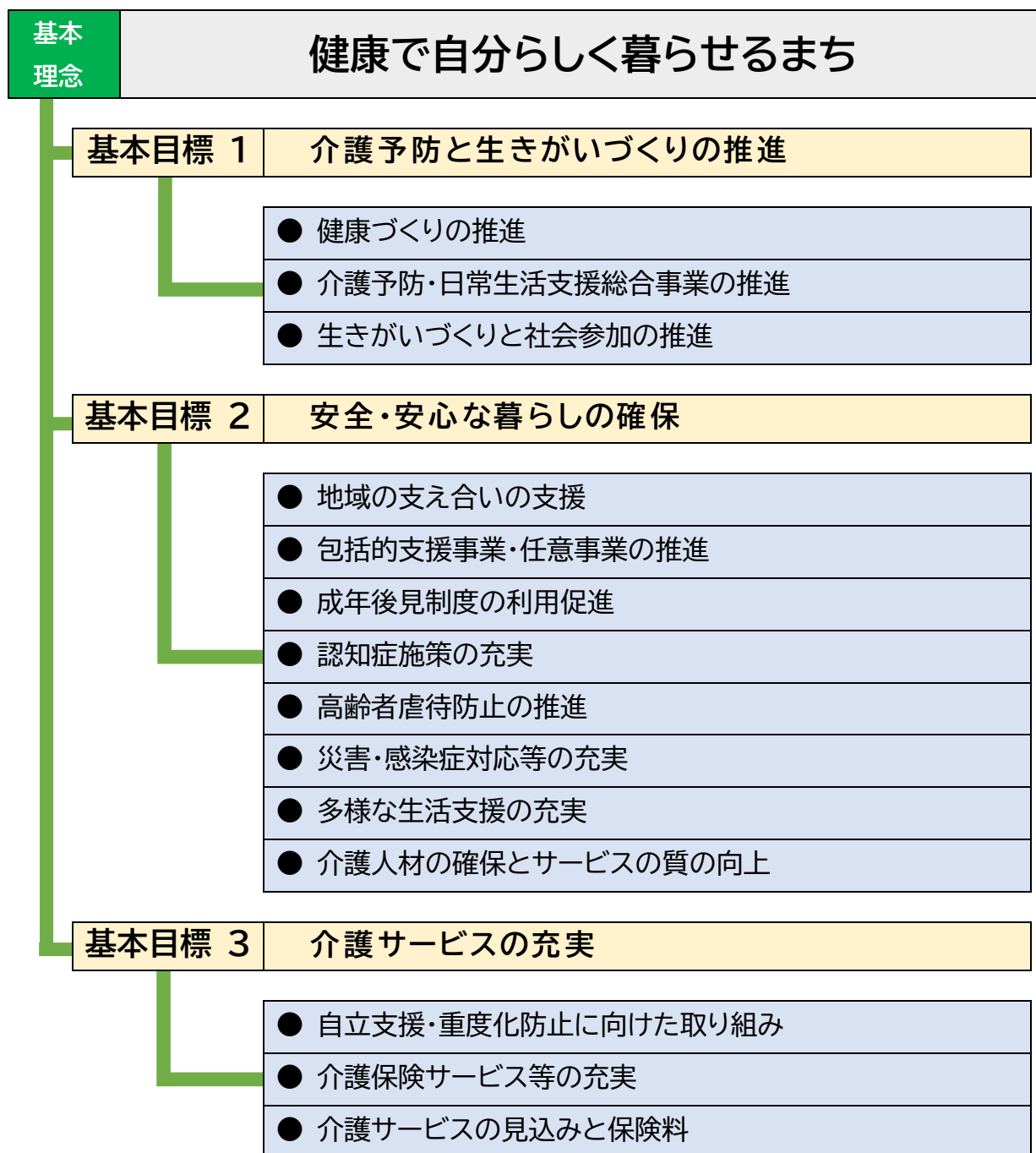
■地域共生社会の姿



厚生労働省『地域共生社会のポータルサイト』より

2 計画の体系

基本理念及び基本目標に基づく、本計画の体系は次のとおりです。



第4章 施策の展開

基本目標1 介護予防と生きがいづくりの推進

1 健康づくりの推進

要介護状態等の原因となる生活習慣病等の予防や、早期発見、早期治療により、健康の保持増進を図るために、健康診査、がん検診等を行います。

前期高齢者に対しては特定健康診査と特定保健指導を、後期高齢者に対しては健康診査と事後指導を行います。その他、すべての高齢者を対象に、各種検診や予防接種のサービスを提供します。

また、要介護状態の原因となる疾患等を防ぐため、健康づくりに関する知識の普及啓発に努めます。

介護予防と健康づくりを一体的に進め健康寿命延伸につなげていきます。

(1) 疾病の早期発見・治療の促進

特定健診をはじめ各種検診を行います。受診率の向上のため、健診の意義についての周知や健診が受診しやすくなるように工夫をし、受診率の向上と疾病の予防、早期発見、治療につなげます。

① 国民健康保険特定健康診査の充実

- ・40歳以上の国民健康保険被保険者を対象として、高血圧症、脂質異常症、糖尿病等の生活習慣病の予防に資するために、特定健康診査及び特定保健指導を実施しています。
- ・特定健診受診率の向上を図るため、新規受診者を増加させることにより全体の受診者を増加させるとともに、継続受診の確保対策として、未受診者に受診勧奨を行います。
- ・長期的な医療費の削減のため、メタボ予備軍を減少させることを目的とした特定保健指導の実施率向上を図ります。

② 後期高齢者健康診査の充実

- ・後期高齢者医療の被保険者を対象として、生活習慣病等の早期発見と重症化予防を図るため、健康診査を実施します。
- ・健診結果に応じた事後指導を実施します。

③ 各種健診の実施とその事後指導の実施

- ・疾病の早期発見・早期治療のため、集団検診の健康診断・検査内容の充実を図ります。
- ・集団検診時に都合が悪い方には、かかりつけ医等で同様の検査ができるよう体制を整えます。

(2) 疾病予防と心身の健康づくりの促進

心身の健康の維持は、高齢者が生きいきと生活していくためには必要不可欠なものです。疾病予防策の充実とともに、介護予防、健康づくりのための各種健康教室の実施や、心身の健康に対する相談体制の充実を図る必要があります。

① 健康教室・相談の充実

- ・健康的な生活を送るため健康教育や老人クラブ等との連携による健康教室を開催します。
- ・潜在化する生活習慣病や疾病を早期に発見し、健康上の不安を解消できるよう、健康相談を実施します。
- ・健康診査などの結果により相談を要する人などを対象に、保健師等による訪問指導を実施します。

② 予防接種の充実

- ・インフルエンザ、肺炎球菌感染症予防のため、65歳以上の高齢者を対象に、各種ワクチン接種を実施し、予防接種費用の一部を助成します。

③ こころの健康づくりに関する保健事業

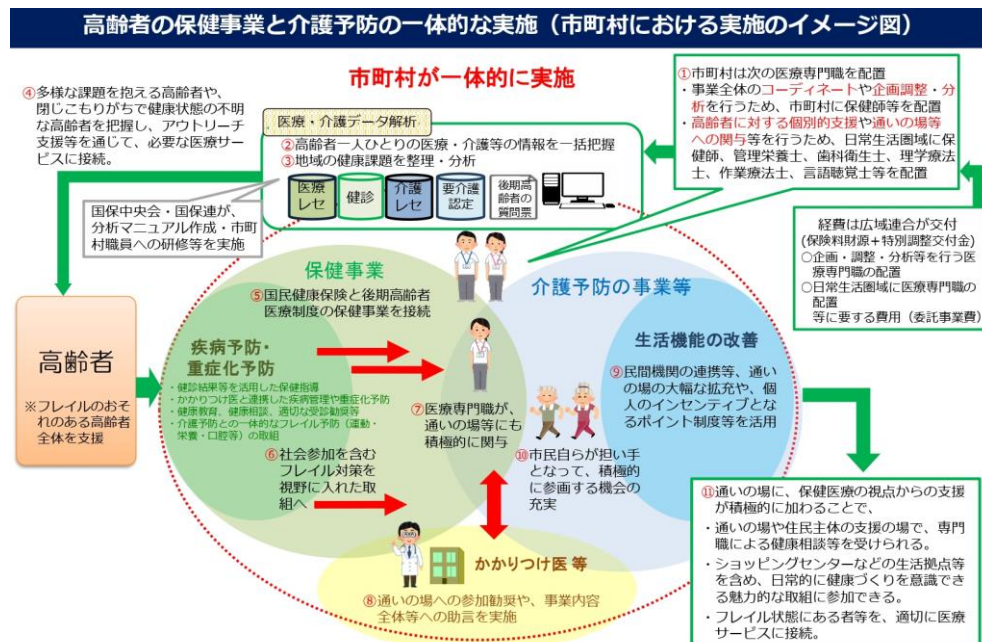
- ・町民が生涯にわたり、こころの健康を保てるよう、相談の機会をつくり、早期支援につなげるとともに、地域でのこころの健康活動を支援する体制づくりを進めます。

(3) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施

高齢になるにつれ、複数の慢性疾患への罹患やフレイルなど高齢者が抱える問題は多くなります。若い年代から、健康づくりの知識を持ち、実践に取り組む人を増やすことで、将来の要介護者を減らすことができます。

高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細やかな支援を実施するため、各ライフステージに応じた健康づくりの施策を展開するとともに、高齢期においても、いつまでも自立した生活を送ることができるよう、町の介護保険、国民健康保険、保健事業の連携を一層強化し、協働することを目指します。

■ 高齢者の保険事業と介護予防の一体的な実施



(4) 地域医療の強化

疾病等へ迅速な対応ができるよう、身近な医療として「かかりつけ医」をもつことを促進します。また、救急医療については田村医師会等との連携を強化するとともに、公立小野町地方総合病院、田村地方夜間診療所を支援していきます。

① かかりつけ医の定着

- ・ 広報等の媒体や健康教室等を通して、最も身近な医療として、かかりつけ医をもつことの大切さを広めます。

② 広域連携の強化

- ・ 本町と田村市、平田村、川内村、いわき市の2市1町2村で運営する公立小野町地方総合病院への支援を継続します。
- ・ 本町と田村市・三春町で設置している田村地方夜間診療所により、引き続き夜間診療体制の充実に努めます。

2 介護予防・日常生活支援総合事業の推進

地域支援事業とは、高齢者が要介護状態になることを予防するとともに、要介護状態となった場合においても、住み慣れた地域で日常生活を送れるよう支援するための仕組みであり、「介護予防・日常生活支援総合事業」、「包括的支援事業」、「任意事業」の3つによって構成されています。

このうち「介護予防・日常生活支援総合事業」では、65歳以上の高齢者の多様なニーズに対して、地域においての生活支援の充実や高齢者の社会参加・支え合い体制づくり、介護予防の推進に努めています。

また、介護予防に関する情報提供をし、身近な場所での普及・啓発を図ります。

(1) 介護予防・日常生活支援サービス事業

介護予防・生活支援サービス事業は、要支援者や基本チェックリスト該当者に対して、要介護状態等となることの予防、要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止、地域における自立した日常生活の支援を実施することにより、一人ひとりの生きがいや自己実現のための取り組みを支援し、活動的で生きがいのある生活や人生を送ることができるように支援します。

日常生活支援として、ミニデイサービス事業やお助けサービスの充実を図ります。

介護予防・生活支援サービス事業は、以下の4つのサービスから構成されます。

① 訪問型サービス

訪問介護	従来の介護予防訪問介護に相当するサービス
訪問型サービスA	人員等を緩和した基準による生活援助等のサービス
訪問型サービスB	住民主体の自主活動として行う生活援助等によるサービス
訪問型サービスC	保健師やリハビリテーション専門職等が行う、体力改善やADL・IADLの改善に向けた短期集中予防サービス
訪問型サービスD	移送前後の生活支援サービス

② 通所型サービス

通所介護	従来の介護予防通所介護に相当するサービス
通所型サービスA	人員等を緩和した基準による運動・レクリエーション等のサービス
通所型サービスB	住民主体の体操や運動等の活動をする自主的な通いの場によるサービス
通所型サービスC	保健師やリハビリテーション専門職等が行う、運動器の機能向上や栄養改善等の短期集中予防サービス

③ その他の生活支援サービス

栄養改善を目的とした配食	栄養改善を目的とした配食や、一人暮らし高齢者に対する見守りをともに行う配食を行います。
住民ボランティア等が行う見守り	住民ボランティア等が行う定期的な見守り訪問による、安否確認及び緊急時の対応を行います。
訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援	地域における自立した日常生活の支援に資するサービスとして、訪問型サービス及び通所型サービスの一体的提供を行います。

④ 介護予防ケアマネジメント事業

- ・自立支援のための身体的・精神的・社会的機能の維持向上を目的に、地域包括支援センターの保健師等が中心となって、個々の状態に応じた介護予防ケアプランを作成し、効果的に介護予防を進めます。

(2) 一般介護予防事業

一般介護予防事業では、65 歳以上の支援を必要としない元気な高齢者を含むすべての高齢者に対して介護予防活動を行うことで、地域における自立した日常生活を維持し、健康で自分らしい暮らしの実現を目指します。

① 介護予防普及啓発事業

- ・高齢者とその家族に対して、要介護状態に陥ることなく健康で自立した生活を送るため介護予防に関する意識の向上に努めます。
- ・介護予防に役立つ基本的な知識の普及啓発のため、パンフレットの配布をはじめ、講演会や相談会、イベント、「ヘルスアップ運動教室」などの介護予防教室等を実施し、介護予防に関連する体力増進と健康づくり、認知症などの正しい知識と理解の普及・啓発を図ります。

② 介護予防把握事業

- ・地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる事業です。
- ・効率的な情報収集に努め、介護予防を必要とする高齢者の早期把握と事業等の利用支援に努めます。

③ 地域介護予防活動支援事業

・地域活動組織等へ介護予防に対する取り組みの紹介や、介護予防に関するボランティア等の人材育成の研修等を通じて、地域における自発的な介護予防に資する活動の育成・支援を行う事業です。各地区で自主的に運営するサロンの運営支援を図ります。

④ 地域リハビリテーション活動支援事業

・地域における介護予防の取り組み機能を強化し、自立支援に資するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民主体の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進します。

3 生きがいづくりと社会参加の推進

地域社会の中で自分の役割があること」や「生きがいを持つこと」は、いつまでもいきいきと暮らしていくための重要な要素であり、高齢者がその豊富な知識や経験、能力を活かしながら、地域社会の中で役割を担って生活することができるよう支援していく必要があります。

多様な社会参加の場に参加することによって、高齢者が生きがいを持って暮らすことができるよう、既存の活動の情報を提供し、高齢者の就労や社会参加促進のための事業やその周知も行っていきます。

(1) 就労機会の拡大

高齢者がこれまで培ってきた豊かな知識と経験を生かし、新たな就労に結びつけることは、高齢者にとって大きな生きがいになり、地域社会にとっても大きな力となります。このため、高齢者の働く意欲に応じた就労の場を確保するとともに、地域活動への参加を促進しながら、高齢者の活躍の場を広げることが重要です。今後もシルバー人材センターによる就業機会の提供や、小野町社会福祉協議会によるボランティアなど社会貢献機会の拡大を図ります。

① シルバー人材センター活動の充実

・高齢者の就業機会を拡大するため、町民に対しシルバー人材センターの活動をPRし、会員の増加や仕事の受注拡大を支援します。
・運営体制強化のため支援を行います。

② ボランティア活動の充実

- ・就労とともに、ボランティア活動などの社会貢献活動も高齢者の生きがいづくり、仲間づくりにもつながることから、町内で実施しているボランティアの内容などの周知を図ります。
- ・高齢者がボランティアとして地域の中で活用できるよう、その動機付けとなる情報の提供やボランティア養成講座を充実させます。

(2) 交流機会の拡充

高齢者が地域で元気に暮らせるよう、孤独を感じている方への、スポーツ、文化活動など外出・交流機会の創出、高齢者が気軽に集まり活動できる場の提供など、高齢者の生きがいづくり、自立した生活の維持を推進します。

今後も、各地区ごとの「高齢者サロン」や「寿大学」や「ニュースポーツ」などの生涯学習・スポーツ活動の充実を図ります。

① 高齢者敬愛事業

- 高齢者の長寿と健康をお祝いするため、75歳の方全員に敬老祝金を、90歳・100歳到達の方には小野町笑顔とがんばり長寿者敬愛条例にもとづき敬祝金を贈呈します。
- ・100歳到達の方には、福島県知事賀寿の贈呈に合わせて町賀寿の贈呈を行います。

② 交流機会の充実

- ・高齢者の交流の機会を拡大するため、週1回程度の「サロン」を開催。自主自立的サロンへの移行を促進します。
- ・介護予防の観点からも、ふれあう機会の拡大は効果的と考えられることから、町内の意欲ある高齢者を町の介護予防教室などの場で介護予防・レクリエーション講師として育成を図ります。将来、各地区でのサロンでの講師・アドバイザーとしての活躍を支援します。
- ・老人憩の家「たかむら荘」を交流・憩いの場として維持管理を継続するとともに、地域活動や高齢者支援活動に対しては積極的に施設を解放します。

③ 老人クラブ

- ・老人クラブ活動は、高齢者の生きがいづくりとなる活動であるとともに、奉仕活動を通じて地域への貢献、地域とのつながりの強化に役立っています。
- ・老人クラブ活動のより一層の活性化を図り高齢者の生きがいや健康づくりを推進するため助成を行います。助成の対象は、60 歳以上の会員が所属する 19 の老人クラブです。
- ・老人クラブ連合会が実施する全町的な芸術・芸能活動、健康増進活動を支援します。
- ・「お元気クラブ事業」を継続して実施し、老人クラブ単位での高齢者の生きがい・健康づくりを支援します。

④ 寿大学

- ・高齢者の生きがいの創出、学びへの意欲に応えるため、文化系の各種講座「寿大学」を開設します。
- ・多様なプログラムを準備し、高齢者の自主的な「学ぶ」活動を支援します。

⑤ ニュースポーツ等の進行

- ・ニュースポーツとして、グラウンドゴルフや軽スポーツなど高齢者に適したスポーツ講習、各種大会等を開催し、健康づくりを支援します。
- ・e スポーツや I C T 活用のための研修等を開催します。

基本目標2 安全・安心な暮らしの確保

1 地域の支え合いの支援

住民主体の支え合いと地域資源の活用により「我が事・丸ごと」の地域づくりを目指す「地域共生社会」の理念が掲げられ、地域における支え合いの体制整備の重要性が叫ばれています。

少子高齢化や核家族化、親族や地縁関係の希薄化など、地域の絆や地域力の低下に対応するため、地域における日常的な見守りや支え合い体制を充実する必要性は非常に高いといえます。

高齢者が地域の中で孤立することがないように、民生児童委員やボランティアによる地域見守り活動を拡充します。高齢者一人ひとりの生活問題に総合的に対応できるよう、生活支援情報の提供や相談窓口を充実します。

(1) 安心ネットワークの形成

高齢者の孤立を防ぎ、誰もが安心して暮らせるまちづくりのためには、公的支援や医療・介護・福祉の専門職による支援とともに、地域住民同士や関係機関の支え合いや見守りの環境を整え、地域におけるセーフティネットを充実していくことが重要です。

① 地域見守り活動の充実

- ・ひとり暮らし高齢者等や徘徊する認知症高齢者を地域で見守るため、不特定で多数の世帯を訪問する機会が多い事業者と見守り協定を締結します。
- ・小野町社会福祉協議会は、町や行政区、民生児童委員と連携し地域の見守り活動を強化します。

② 相談窓口の充実

- ・多様化・複雑化する生活問題に対応するため、福祉等関連情報の提供に努めるとともに「町健康福祉課」「地域包括支援センター」「社会福祉協議会」の3箇所の窓口で相談に対応します。
- ・窓口では、相談者の訪問対応のほか、積極的に現場を訪問するなど実態の把握に努めます。

2 包括的支援事業・任意事業の推進

本町では、地域包括ケアシステムの推進に向けて、高齢者の社会参加・介護予防に向けた取り組み、配食・見守り等の生活支援体制の整備、在宅生活を支える医療と介護の連携及び認知症の方への支援の仕組み等を一体的に推進しながら高齢者を地域で支えていく体制を構築するため、「介護予防・日常生活支援総合事業」、「包括的支援事業」、「任意事業」の3事業から構成される地域支援事業の実施を推進しています。

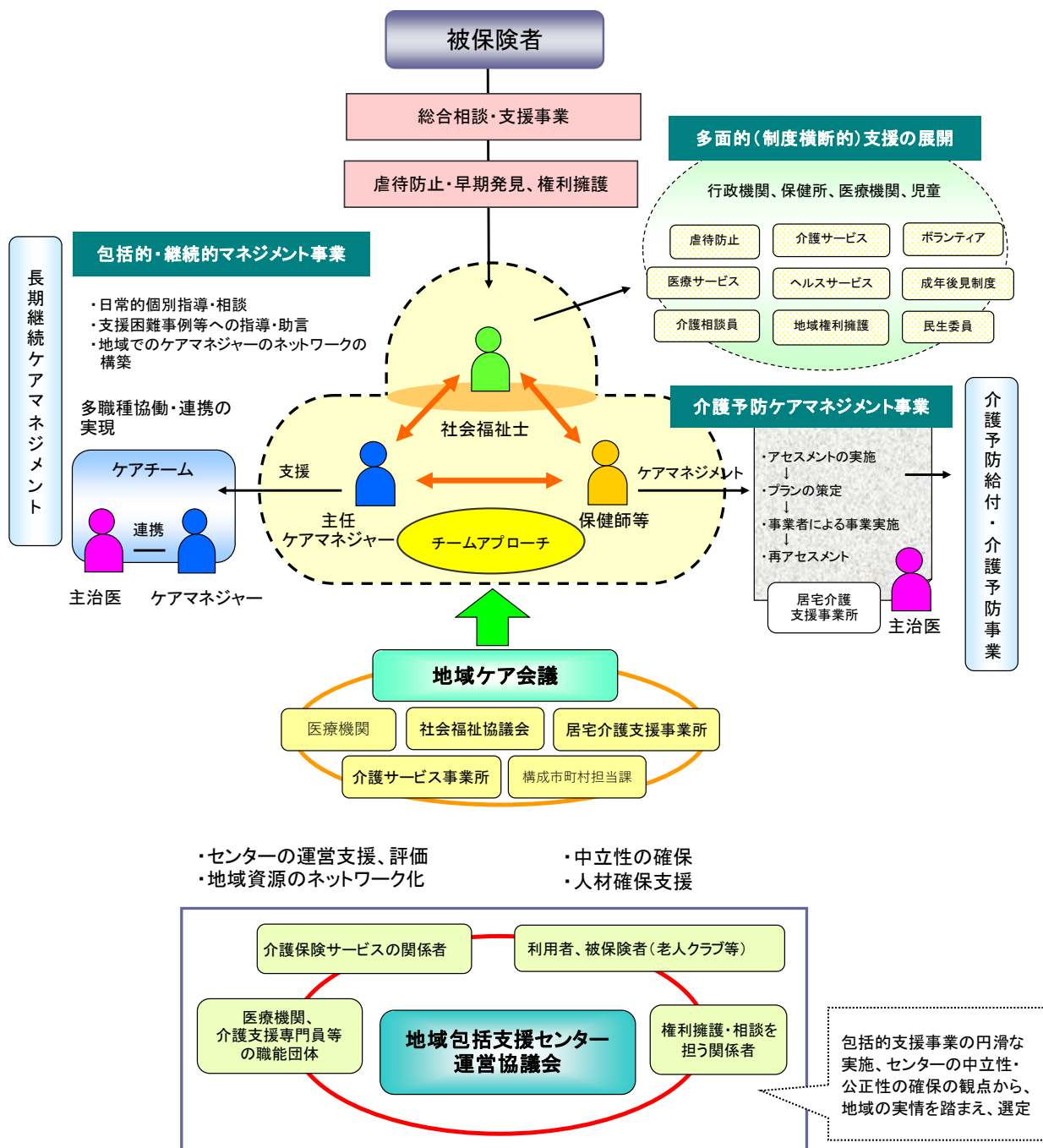
地域支援事業のうち「包括的支援事業」では地域包括支援センターにおける総合的な相談支援等、地域の高齢者を包括的に支援するための取り組みを実施し、「任意事業」では地域の実情に寄り添った多様な支援を行うことで、より有効で持続可能な介護サービスの提供を目指しています。

(1) 地域包括支援センターの体制強化

今後の高齢化の進展等により増加すると考えられるニーズに適切に対応し、持続可能な支援を推進していくため、外部委託や地域の社会資源との連携も図りつつ、業務負担軽減を進めるとともに体制の整備も含めた効果的な運営手法を確立していくことが求められています。

- ・地域包括支援センターの活動強化のため、豊富な現場経験を有する小野町社会福祉協議会に運営を委託し、機能の強化を図ります。
- ・地域包括支援センターは、地域の高齢者等見守り体制づくりや高齢者支援体制の強化のため各種団体・多職種間の連携に努めます。

■地域包括支援センターの体制と機能



(2) 包括的支援事業

「包括的支援事業」では地域包括支援センターにおける総合的な相談支援等、地域の高齢者を包括的に支援するための取り組みを実施します。

① 総合相談支援事業

- ・地域包括支援センターの社会福祉士を中心に、住民の各種相談を幅広く受け付けるとともに、苦情の受付等についても窓口となって対応しています。
- ・地域における様々な関係者とのネットワーク構築を図り、サービスに関する情報提供等の初期相談対応や、支援方針に基づく様々なサービス等への利用のつなぎ機能などの継続的・専門的な相談支援を行い、制度横断的、多面的な支援を展開します。

② 権利擁護事業

- ・実態把握や総合相談支援の中で、判断能力が不十分のため日常生活に困っている高齢者等に対して、安心して日常生活が送れるようにするために、専門的・継続的視点から権利擁護のために必要な支援を行います。
- ・高齢者の虐待については、「高齢者虐待防止法」により、虐待発見者には市町村への通告義務があり、市町村は虐待を受けた高齢者を保護する責務が定められています。

③ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

- ・高齢者一人ひとりの状態の変化に対応した長期的ケアマネジメントを実施します。
- ・介護サービスの地域均等化やその技術、マネジメント機能を強化するため、介護支援専門員を中心に介護支援推進会議を開催します。
- ・介護支援推進会議では、介護制度や事例の検討、専門家を招き講演会を行うなど、資質の向上を図ります。

④ 地域ケア会議の充実

- ・地域ケア会議は、地域包括ケアシステムの構築を実現するために、高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備とを同時に進める手法の一つです。
- ・住み慣れた地域で最後まで自分らしくいられるよう関係団体及び関係機関と連携し、地域課題、個別ケースを検討する会議を開催します。

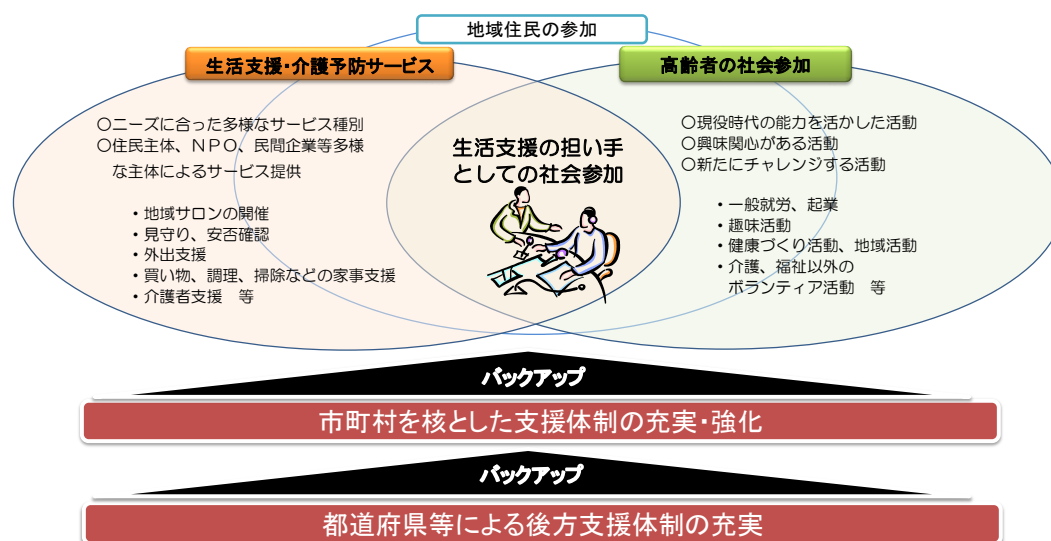
⑤ 在宅医療と介護連携の強化

- ・医療と介護の両方を必要とする高齢者を地域で支えていくためには、在宅医療と介護の一体的な提供が必要です。そのため、医師に加え歯科医師、薬剤師、看護師、リハビリ専門職、介護職等の多職種連携を推進します。
- ・医療・介護関係者が在宅で療養する高齢者の状態の変化等について速やかに対応できるよう、情報端末の利用など効率的な連絡調整方法や情報共有の方法を検討、実施します。

⑥ 生活支援体制整備事業

- ・生活支援・介護予防サービスの体制整備に向け、地域においてサービス提供体制の構築に向けたコーディネート機能（資源開発やネットワーク構築の機能など）を担う「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」を配置します。
- ・定期的な情報共有や連携強化のためのネットワークとして、生活支援コーディネーターやサービスの提供主体等で構成する「協議体」を設置し、情報共有や連携・協働による資源開発等の推進を図ります。
- ・今後も一人ひとりのニーズにきめ細かに応えるために、生活支援コーディネーターを中心にボランティア、NPO、民間企業等や老人クラブ、地域活動団体などと協働によりサービスの充実・強化を図ります。

■生活支援体制整備事業



(3) 任意事業

地域の実情に寄り添った多様な支援を行うことで、より有効で持続可能な介護サービスの提供を目指します。

① 介護給付適正化事業

- ・介護給付の適正化と必要なサービスの提供を図るため、介護給付費の適正化に努め、介護保険の健全な運営を推進します。
- ・給付適正化主要5事業が3事業に再編されたことを受け、主要3事業となる「要介護認定の適正化」、「ケアプランの点検」、「縦覧点検・医療情報との突合」について取り組みます。

② 介護用品給付券事業

- ・在宅で介護する家族の経済的負担を軽減するため、介護用品と引き換えることができる介護用品給付券を交付します。なお、国等の補助制度の見直しを見据え、介護保険事業から高齢者福祉事業への転換を検討します。

3 成年後見制度の利用促進

成年後見制度は、認知症高齢者、知的障がいなどで判断能力が不十分な方などに対して、財産管理や身上監護（介護施設への入所・退所）についての契約や遺産分配などの法律行為等を自分で行うことが困難な方々を保護し支援する制度です。

認知症等により判断能力が不十分な高齢者の増加が予想されるため、成年後見制度及び成年後見制度利用支援事業の普及が図られるように、成年後見制度普及啓発のための取り組みを推進します。

(1) 成年後見制度利用促進のための体制整備

本人や家族、地域住民、福祉の関係者に制度を周知するため、制度内容の周知や研修会や講演会等を開催するとともに、相談窓口を明確化することで、相談しやすい環境を整備します。

- ・住み慣れた地域で最後まで暮らすために、町民一人ひとりの人権を尊重し、ともに認め合うことのできる地域を目指します。
- ・自分らしい生活を送るうえで、認知症により意思決定を十分に主張することができない方の「権利擁護」や「意思決定支援」を行うため成年後見制度の利用を促進します。

■ 成年後見制度

成年後見制度は、「任意後見制度」と「法定後見制度」に分類されます。

「任意後見制度」は、本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ本人が選んだ方に、代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度です。本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、契約の効力が生じます。

「法定後見制度」は、本人の判断能力が不十分となった後に、家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見人等が選ばれる制度です。また、「法定後見人制度」は、判断能力の程度に応じて、さらに「後見」、「補佐」、「補助」の3つの種類に分けられます。

■ 成年後見制度の種類

	任意後見	法定後見
利用できる人	本人の判断能力が「ある人」	本人の判断能力が 不十分な人（補助） 著しく不十分な人（保佐） ほとんどない人（後見）
後見人を選出する人	本人 （自分で決めることができる）	家庭裁判所
監督する人	任意後見監督人 （家庭裁判所により選出）	家庭裁判所 （親族が後見人となる場合など、 監督人が選任される場合もある）
後見の内容	本人の希望をもとに内容を決める （契約で決めた内容）	あらかじめ定められている （補助・保佐・後見により異なる）
法律行為の取消権	取消権がない	家庭裁判所が決める

成年後見制度利用促進 現状と課題

- ・人口減少が加速し家族の在り方や地域コミュニティの在り方が課題となる中で成年後見制度の利用を必要としながら利用できていない精神障がい者、知的障がい者が多いと考えられます。
- ・成年後見制度の必要性は、今後高まることが予測されます。このような現状と課題を解決するためにニーズの把握、広報、支援等体制整備が重要となります。

成年後見制度利用促進 施策目標

- ・成年後見制度を必要とする方が、自分らしい生活を守るため制度利用ができるよう権利擁護支援の地域連携ネットワークを構築します。
- ・ネットワークの役割は次のとおりです。
 - (ア) 権利擁護支援の必要な人の発見・支援
 - (イ) 早期の段階からの相談・対応体制の整備
 - (ウ) 意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度利用の運用に資する支援体制の構築

成年後見制度利用促進 施策方針

- ・地域連携ネットワーク構築のためには「中核機関」の整備・運営が重要となります。地域連携ネットワークおよび中核機関の具体的な機能と方針は次のとおりです。
 - (ア) 広報啓発機能
 - 広報啓発を行うことで、制度理解を深め権利擁護が必要な方の早期発見につなげます。
 - (イ) 相談機能
 - 権利擁護に関する支援が必要な場合に関係者の相談に応じ、ニーズの把握、情報の収集を行い、必要な体制整備の支援に取り組みます。
 - (ウ) 成年後見制度利用促進及び後見人支援機能
 - 受任者調整、法人後見、町民後見人の育成を行います。

成年後見制度利用促進 助成制度の在り方

- ・小野町成年後見制度利用支援助成金事業実施要綱による適正な助成を行い、社会情勢に合わせて利用できるよう支援拡充を検討します。

(2) 消費者被害の防止

高齢者が消費者被害に遭わないよう防犯の啓発と相談体制の整備を図ります。

- ・悪質商法による高齢者の消費者被害が増加するとともに、悪質商法の手口が多様化していることから、地域包括支援センターや消費生活センター、警察と連携し消費者被害に関する相談事例等を積極的に周知することで、未然防止のための注意喚起を促す取り組みを行います。

4 認知症施策の充実

認知症の人やその家族が、地域のよい環境で自分らしく暮らし続けるためには、認知症への社会の理解を深め、認知症があっても、同じ社会の一員として地域をともに創っていく必要があります。そのためには、認知症に関する正しい知識と理解の普及啓発を進めていく必要があります。

行政による普及啓発の取り組みだけではなく、地域で暮らす認知症の方とともに普及啓発を進め、認知症の人本人が自らの言葉で語り、認知症になっても希望を持って前を向いて暮らすことができている姿等を積極的に発信していくことが大切です。

認知症施策においては、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人やその家族の意見も踏まえながら、「共生」と「予防」の施策を推進することが重要です。

本町では、「認知症基本法」、「認知症施策推進大綱」の考えに沿って、認知症施策の推進を図ります。

(1) 普及啓発・本人発信支援

認知症サポーターの養成等を通じた、認知症に関する理解促進や相談機関の周知、認知症の人本人からの発信支援に取り組みます。また、認知症に関する正しい知識と理解に基づき、予防を含めた認知症への「備え」としての取り組みを推進します。

① 認知症サポーター養成講座の開催

・地域住民や関係団体、将来を担う若者などを対象に認知症を正しく理解してもらい、認知症の人や家族を温かく見守る応援者（サポーター）を養成する講座を開催します。

(2) 予防（早期発見・早期対応）

認知症の予防とは、「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味です。

認知機能低下のある人や認知症の人に対しては、早期発見・早期対応が行えるよう、かかりつけ医、地域包括支援センター、認知症地域支援推進員、認知症初期集中支援チーム等のさらなる質の向上や連携の強化を推進します。

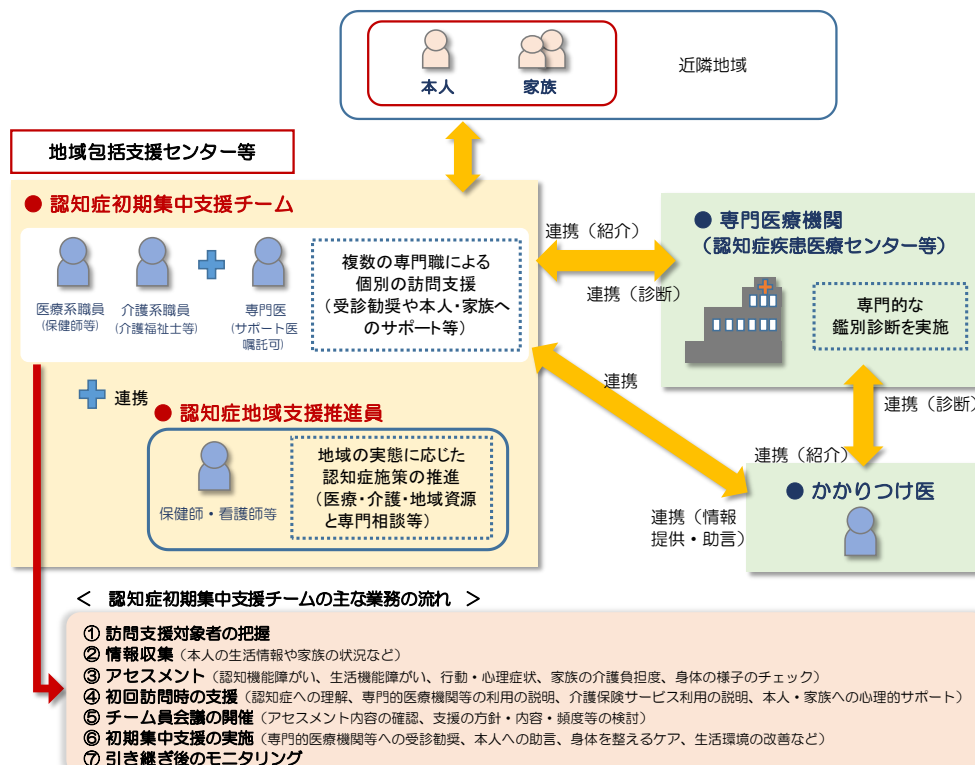
① 認知症ケアパスの普及

- ・ 今後、増えると予想される認知症高齢者に対し、切れ目のないサービスが提供できるよう、また、本人や家族、地域での認知症への理解の拡大や早期発見のため、認知症ケアパス（認知症の症状に応じた適切なサービスの流れ）の更なる普及を図ります。

② 認知症初期集中支援事業

- ・ 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるように、訪問支援対象者及びその家族に対する初期支援を包括的かつ集中的に行い、自立生活を行うため、小野町認知症初期集中支援チームを配置し、活動を推進します。

■認知症施策の推進体制のイメージ図



(3) 医療・ケア、介護サービス・家族介護者への支援

早期診断・早期対応のため、福祉・介護分野との支援体制の充実・強化・連携を図ります。また、認知症の人の介護者への支援を行うことは、認知症の人の生活の質の改善にもつながるため、家族など介護者（高齢介護者やヤングケアラー）の精神的身体的な負担の軽減や、生活と介護の両立を支援する取り組みを推進します。

① 認知症に対応した介護サービスの提供

・認知症の状況に応じた適切な介護サービスを提供できるよう、介護サービス基盤整備や介護人材確保、介護従事者の認知症対応力向上のための取り組みを進めます。

② 認知症カフェの拡充

・認知症の人とその家族、地域住民、専門職が気軽に集え、認知症の人を支えるつながり等を支援する認知症カフェの運営支援を行います。

③ 認知症ケアに携わる多職種研修の促進

・認知症について、介護も医療も生活の一部であることを十分に意識し、介護と医療関係者が相互の役割・機能を理解しながら、統合的なケアにつなげていくため、介護と医療に携わる専門職を対象に、講演会や事例検討会を開催します。

④ 家族介護者への支援

・認知症の人の介護者への支援を行うことは、認知症の人の生活の質の改善にも繋がるため、家族など介護者の精神的身体的な負担の軽減や、生活と介護の両立を支援する取り組みを推進します。また、認知症の人を介護する家族同士が交流できる場を設けることで、同じような悩みや苦勞を話し合える機会をつくり、介護する家族の支援を図ります。

5 高齢者虐待防止対策の推進

養護者、養介護施設従事者による高齢者虐待は全国的に増加の傾向が見られます。高齢者虐待の早期発見に向けて、住民に対し高齢者虐待に対する相談窓口や知識の普及・啓発を行うことが重要です。

また、虐待を未然に防ぐ環境づくり推進のため、介護従事者などに対し定期的に研修会を開催するとともに、介護保険サービス事業者や、民生委員・児童委員、警察、医療機関などの関係機関と連携を強化し見守り体制の充実を図っています。

(1) 高齢者虐待防止に向けた体制整備の強化

高齢者人口の増加に伴い、「高齢者虐待防止法」が平成 17 年に施行されましたが、養護者、養介護施設従事者による高齢者虐待は全国的に増加の傾向が見られます。

高齢者虐待の早期発見に向けて、住民に対し高齢者虐待に対する相談窓口や知識の普及・啓発を行うことが重要です。

また、虐待を未然に防ぐ環境づくり推進のため、介護従事者などに対し定期的に研修会を開催するとともに、介護保険サービス事業者や、民生児童委員、警察、医療機関などの関係機関と連携を強化し見守り体制の充実を図っています。

① 普及啓発と職員の資質向上

- ・ 高齢者虐待の防止や早期発見のため、広報などを通じて相談窓口の周知を行い、高齢者の権利擁護に関する普及啓発を行います。
- ・ 対応マニュアルの作成や、定期的に研修会を開催し、町や地域包括支援センター職員、介護従事者の迅速かつ適切な対応力向上を目指していきます。

② 多職種連携の推進

- ・ 早期発見・見守り、保健医療及び福祉サービスの介入支援、関係機関介入支援などを図るためのネットワークを構築し、多職種に連携を図りながら支援していきます。
- ・ 警察に対する援助要請や、老人福祉法に基づく措置を行うために必要な居室の確保等に関して関係機関等の連携及び調整を図り早期解決を目指します。

6 災害・感染症対応等の充実

近年、自然災害が全国的に多発しており、台風や地震等による被害も大きくなっています。高齢者や障がい者などの避難行動要支援者の安全を守るためには、避難訓練の実施や防災啓発活動、物資の備蓄・調達状況の確認といった災害への備えと、災害発生時に迅速に避難・救助ができる体制を整備する必要があります。

また、新型コロナウイルスによる影響は、これからの感染症対策の在り方を再考するきっかけとなりました。「新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づく感染症拡大防止の取り組みや、介護事業所、保健所、医療機関と連携した感染症発生時の支援体制の構築を推進し、高齢者の健康の確保に努めます。

(1) 地域の防災対策の推進

支援を要する高齢者等の把握に努めるとともに、総合的かつ計画的な防災対策の推進、災害時対応の体制づくりに努めます。また、地域における住民の取り組みを促進し、民生児童委員等を中心とした見守り活動や各地区の自主防災組織による高齢者支援の仕組みづくり、介護サービス事業所等における災害対策に係る計画等の策定、訓練等の実施や、必要な物資の備蓄・調達の状況を定期的に確認し、関係機関等とも連携した取り組みを進めます。

① 避難行動要支援者の支援体制の整備

- ・ひとり暮らしの高齢者や障がい者などの避難に支援が必要な方を地域全体で支えることが求められることから、避難行動要支援者名簿の整備と活用を図ります。
- ・避難行動要支援者名簿の定期的更新と個別避難計画の策定を推進します。
- ・名簿は、地域の民生児童委員、行政区長、消防団、小野町社会福祉協議会、消防署、警察署などと共有し、災害時の安否確認や避難支援などに活用します。

② 福祉避難所の設置

- ・高齢者や障がいをもった方など特別な配慮が求められる方々を受け入れる福祉避難所を設置します。福祉避難所の多くは、民間の介護事業所を活用します。
- ・拠点福祉避難所を小野町デイサービスセンターとし、日ごろより資材等の備蓄を行います。
- ・福祉避難所のほかに、福祉に関する豊富なノウハウを有する人材や福祉機器の調達、高齢者等の移送の支援を受けたいことから協力事業所と協定を締結します。

③ 災害対策計画の作成と避難訓練の実施の推進

- ・突発的に発生する災害に備え、介護施設における非常災害対策計画及び避難確保計画を作成し、避難訓練の実施を推進します。

(2) 感染症対策の推進

感染症に対する備えとしては、日頃から介護事業所等と連携し、感染症拡大防止策の周知徹底、感染症予防等に係る物資の事前備蓄、感染症発生時の代替サービス確保に向けた連携体制の構築等を行うことが極めて重要となります。

① 感染症対応の知識の普及、支援体制の整備

- ・介護事業所等の感染症発生時におけるサービス提供体制や対応計画を定期的に確認するとともに、感染症に係る研修会等を実施し、職員や関係者の感染症に対する理解や知見を深めていきます。
- ・県や保健所、協力医療機関等と連携した支援体制の整備や、介護事業所等において感染症対策に必要な消毒液等の物資の備蓄・調達・輸送体制の整備に努めます。

7 多様な生活支援の充実

高齢者の増加により細かな生活支援へのニーズが高まっています。増加しているひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯といった高齢者のみの世帯の生活を支える視点からも、医療、介護サービスの充実に図るとともに、日常生活を支援する生活支援のサービス体制を充実させる必要があります。

できるだけ多様な主体（NPO、民間企業、協同組合、社会福祉法人、ボランティア、地域住民等）による高齢者と地域社会とを密接に結びつける地域のつながりづくりを進めていくことが重要になります。

移動支援や生活支援の充実に向けては人材の確保は切り離すことはできません、今後は人材の確保に向けた取り組みを推進します。

(1) 生活基盤の確保

高齢者が安心して住み続けられる生活環境を築くためには、身体状況に適した住まいの確保や、緊急時の通報等の安心できる基盤の整備が重要です。

個々の状況やニーズに沿った多様な住まいを確保と生活支援の一体的な実施を推進します。

① 高齢者住宅改修の助成

- ・高齢者が自宅で転倒などにより要介護状態にならないよう、住宅改修を実施する人へ改修資金を助成（助成限度額は180,000円）します。

② 老人ホームなどへの入所措置

- ・身体上、精神上又は環境上の理由及び経済的理由により在宅での生活が極めて困難で、高齢者の福祉に欠けると認められる高齢者を老人ホームに入所させます。本人や家族の状況をよく確認し、適切な処遇を図ります。

③ 県、近隣市町村との情報連携の強化

- ・老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は、高齢者の多様な住まいのニーズの受け皿として重要な役割を果たしている一方で、併設する介護事業所から過不足のないサービスが提供されているかなど、様々な課題が指摘されています。町では県や近隣市町村との連携を強化し、施設の設置状況や介護サービスの提供状況などの把握に努めます。

④ 緊急通報システムの普及

- ・ひとり暮らし高齢者や障がい者が安心して地域で生活ができるよう、急病や災害等の緊急時に消防機関や近隣の支援者に通報し、迅速かつ適切な対応を図ることができる特殊電話（緊急通報システム）を貸与します。

⑤ 生活困窮世帯への相談・支援

- ・生活困窮世帯を支援するため、民生児童委員などと連携し相談・支援の充実を図ります。

(2) 交通利便性の向上

高齢になっても、今まで暮らしてきた地域で不自由なく生活するには、移動・外出は欠かせません。公共交通機関の利便性の向上とともに、外出支援事業、道路等のバリアフリー化も重要です。

① 公共交通の維持

- ・高齢者の身近な交通手段を確保するため、JR 磐越東線とバス路線存続に努めます。

② 交通弱者対策の推進

- ・平成 29 年度から実施しているタクシー利用料金助成制度の周知に努め、交通弱者対策に努めます。

③ バリアフリー化の推進

- ・今後、関係各課との連携により、公共施設の改修、整備によるバリアフリー化を推進するとともに、車道と歩道の段差解消、歩道整備など歩行空間のバリアフリー化を推進します。

(3) 福祉サービスの充実

高齢者で一人暮らしの人や高齢の夫婦のみ世帯などのすべての高齢者ができるだけ身近な地域で暮らし続けていくためには、それぞれのニーズにあった在宅福祉サービスが必要です。

地域における支え合いを推進しつつ、地域の力だけでは実現が難しい生活課題や福祉課題に対応し、在宅生活を継続しやすくするための福祉サービスの充実を図ります。

① 高齢者お助けサービス事業

- ・介護保険対象外のひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯を対象に、買い物や家事、庭木の手入れ等日常生活における軽易な作業を有償でお手伝いします。
- ・地域での支援意識の拡大を図るため、民間団体に委託して事業を実施します。

② 生活支援ショートステイ事業

・生活支援ショートステイ事業では介護する家族に緊急やむを得ない事情があり介護が欠ける場合や虐待等により緊急に隔離する必要がある場合、特別養護老人ホームの空床を利用し短期間宿泊させ、介護を要する高齢者の福祉向上を図ります。

③ 老人福祉施設の適切な維持管理

・老人憩の家「たかむら荘」（愛称：ゆ～ゆ～こまち）は昭和 50 年度より気軽に利用できる温浴施設として親しまれてきました。今後も維持管理に努め、より利用しやすくなるよう適正な施設運営に努めます。

・屋内ゲートボール場は高齢者の健康づくりのため設置され、小野町ゲートボール協会の管理により素晴らしい環境が維持されています。今後も高齢者の健康づくりの拠点施設となるよう維持管理に努めます。

④ 配食サービス

・栄養改善を目的とした配食やひとり暮らし高齢者に対する見守りとともに行う配食サービスです。身体や世帯の状況等により、食事をつくるのが困難な高齢者に対して、バランスのとれた弁当を配達し、合わせて安否確認を行うことにより高齢者の在宅生活の維持を図ることを目的に、本計画期間中に配食サービスを開始するべく検討していきます。

⑤ 介護離職ゼロに向けた取り組み

・要介護状態等にある家族を介護するための離職（介護離職）を防止する観点から、働きながら介護に取り組む家族等や、今後の仕事と介護の両立に不安や悩みを持つ就業者の実情等の把握に努めるなど調査方法等の工夫を図ることが重要となっています。介護離職ゼロを達成するように整備を行います

8 介護人材の確保とサービスの質の向上

生産年齢人口が減少する中、介護サービスを担う介護人材の不足が全国的な課題となっています。

本町においても、高齢化の進展に伴い介護や生活支援への需要は今後ますます高まると考えられ、介護人材の確保・育成や定着が急務となります。また、介護サービス提供における業務量の過多による介護従事者の負担を軽減するため、ICTの導入等を通じた業務の効率化に努める必要があります。

必要となる介護人材の確保に向け、国や県と連携し、介護従事者の処遇改善、新規参入やボランティア等多様な人材の活用の促進、介護の仕事の魅力向上、職場環境の改善など、人材の「確保」、「定着」、「育成」の視点から総合的な取り組みを推進します。県が実施する施策を周知し、その取り組みなど積極的に参画していきます。

(1) 介護人材の確保・質の向上

介護現場が地域における介護ニーズに応え、介護人材が利用者や家族からも感謝され、やりがいを持って働き続けられる環境づくりを進めます。そのため、職場の良好な人間関係づくりや結婚、出産、子育てを続けながら働ける環境整備を介護サービス事業者に対して協力要請していきます。

① 介護人材の確保に向けた取り組み

- ・介護現場における業務仕分けや介護ロボットやICTの活用による生産性の向上、必要となる介護人材の確保に向け、国や県と連携し、介護者の処遇改善、新規参入や元気高齢者や外国人など多様な人材の活用の促進、介護の仕事の魅力向上、職場環境の改善等、人材の「確保」、「定着」、「育成」の視点から総合的な取り組みを推進します。
- ・離職中の介護福祉士等の有資格者に対し、介護分野への再就職に向けた不安感を払拭するため、町の介護保険関連の情報提供や最新の介護技術に関する研修やセミナーの実施など、再就職を促す取り組みを進めます。
- ・疾病や加齢等により日常の医療的ケアが必要となった高齢者が、住み慣れた自宅で療養生活を送るためには、医師の指示に基づき看護師が高齢者宅を訪問して行う訪問看護が不可欠です。訪問看護ステーションが主催する研修等との連携、県事業の周知などを通して看護師の資格を持つ方の再就職や訪問看護事業者を支援し、訪問看護人材の確保を図ります。

- ・介護ニーズが高度化・多様化する中、介護職員の育成・専門性向上のための研修や、医療と介護の連携強化を図る研修などを実施します。
- ・町内の介護サービス事業所で働く職員が、仕事に対する誇りとやりがいを持って働き続けることができるよう、経営者等に対する労働環境の改善をテーマにした研修の実施や、意欲や能力に応じたキャリアパス制度の導入・運用支援を行います。
- ・今後、一層高まる介護サービス需要に対応するため、福祉分野への多様な人材の新規参入を促進するための取り組みや、次世代を担う小・中・高校生の福祉職場への興味や関心を高め、就労のきっかけづくりとなるような取り組みを進めます。
- ・介護職員として従事することを希望する方への就労支援や、介護サービス事業所に就労している方の資質向上を目的とした介護職員初任者、介護福祉士実務者の資格を取得するための研修費の一部助成を行います。

■介護人材の確保に向けた取り組み

確保	介護の仕事の魅力の発信、元気高齢者や外国人など人材の新規参入の促進、有資格者の掘り起し等の人材の確保
定着	介護職に就いた人材が長く働けるよう、キャリアアップ確立の支援やハラスメント対策など働きやすい環境づくり等事業者を支援
育成	質の高い介護サービスを安定的に提供できるようにするため、各種研修支援等のスキルアップを支援

基本目標3 介護サービスの充実

1 自立支援・重度化防止に向けた取り組み

高齢者が要介護状態になることを防ぎ、要介護状態になっても状態をそれ以上悪化させないようにするため、生活上の様々な課題を抱える個々の高齢者の実態に即した支援を行い、地域支援事業や予防給付、医療保険者による保健事業などのサービスが、連続性・一貫性を持って提供されるよう体制づくりに努めます。

(1) 保険者機能の強化に向けた取り組み

地域包括ケアシステムを深化・推進するためには、PDCAサイクルを活用して保険者機能を強化していくことが重要です。

この一環として、高齢者の自立支援、重度化防止等に関する取り組みに対する自治体の様々な取り組みの達成状況の評価に応じ、国から自治体への財政的インセンティブとして交付される「保険者機能強化推進交付金」が平成29年度に創設され、令和2年度には介護予防・健康づくり等に資する取り組みに対する取り組みの達成状況の評価に応じて交付される「介護保険保険者努力支援交付金」が創設されました。

これらの交付金はそれぞれの評価指標の達成状況に応じて交付金が交付されるもので、保険者は自らの取り組みの評価や、新たな取り組みの指標として活用します。

当町においても、交付金評価指標を活用し、施策・事業の評価、新たな取り組みについて検討していきます。

(2) 介護給付適正化事業の確実な実施

介護給付費が適正に支給されているか、効果のある介護サービスが行われているか等の状況を正確に把握することで、透明性が高く、公正かつ効率のよい介護保険制度の運用を図ります。

これまでは介護給付等費用適正化事業として、①要介護認定の適正化、②ケアプランの点検、③住宅改修等の点検、福祉用具購入・貸与調査④縦覧点検・医療情報との突合、⑤介護給付費通知を主要5事業としてきましたが、第9期計画期間においては、介護給付費通知を任意事業とし、ケアプランの点検に住宅改修等の点検、福祉用具購入・貸与調査を統合した主要3事業として適正化事業を実施することとなりました。

① 要介護認定の適正化

- ・保険者が、指定居宅介護支援事業所等に委託している区分変更申請や更新申請に係る認定調査の結果について、保険者による点検の実施を通じた要介護認定の適正化を図ります。

② ケアプランの点検【住宅改修等の点検、福祉用具購入・貸与調査の点検】

- ・利用者の自立支援に資する適切なケアプランであるか等に着目し、保険者がケアプランの点検を実施します。これにより、利用者に対する質の高いサービス提供を通じた介護給付の適正化を図ります。

③ 縦覧点検・医療情報との突合

- ・保険者が複数月の請求明細書の内容を確認し、提供されたサービスの整合性の点検を行うとともに、保険者が医療保険の入院情報等と介護保険の給付情報を突合し、二重請求の有無の確認を行います。

2 介護保険サービスなどの充実

本町では、町民はじめ、事業者や協力団体、関係機関等との連携を引き続き図っていくことで、町内の事業運営が滞ることなく運用していくことのできる環境を整備します。

(1) 日常生活圏域の設定

日常生活圏域は、高齢者が住み慣れた地域において可能な限り生活を続けることができるよう、高齢者と地域の実状に応じて介護サービス基盤を空間的に考える基本単位として設定するものです。特に、地域密着型サービスについては、その特性からサービス量を日常生活圏域ごとに見込むこととされています。

本町では、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービス提供施設の整備状況などを総合的に勘案して検討を行い、第9期についても第8期計画と同様、日常生活圏域は町全域で1圏域が望ましいと判断しました。

小野町の日常生活圏域 ▶ 町全域1圏域

(2) サービスの質の向上と利用者支援の充実

利用者に質の高い適切なサービスが提供されるよう、ケアマネジャー等に対する支援や、介護事業者に対する適切な助言を行うとともに、指導や監査の強化等に取り組んでいきます。

① 介護保険制度の周知

・介護保険サービスを利用する高齢者や町民に対して、制度改正における変更点や、保険料などの情報を分かりやすく伝えるため、広報紙や、パンフレット、ホームページなどで情報の提供を図ります。

② 苦情処理と相談体制

- ・介護保険サービスへの苦情に対しては、必要に応じて担当の介護支援専門員や地域包括支援センターへ情報提供し、内容・経緯を確認するなどの対応を行います。
- ・事業所や本町での対応が難しい苦情や問題があった場合には、必要に応じて県や国保連合会と連携し、適切な問題解決に努めます。

③ 指導・監督

- ・地域密着型サービス事業者及び居宅介護支援事業者に対しては、身近な保険者としての機能を活かして、指導・監督を実施し、質の高いサービス提供の確保に努めます。

(3) 文書負担軽減に向けた取り組み

業務の効率化の観点からは、介護現場におけるICTの活用を進めるとともに、介護分野の文書に係る負担軽減を図るため、個々の申請様式・添付書類や手続きに関する簡素化、様式例の活用による標準化やICT等の活用を進める必要があります。

そのため、国や県、本町・関係団体等がそれぞれの役割を果たしながら、連携して介護事業者や保険者の業務効率化の取り組みを進めます。

3 介護サービスの見込みと保険料

介護が必要な状態となった高齢者への支援の充実を図るため、必要とする人が必要とするサービスを確実に受けられるよう、近隣市町村との連携を図りながらサービスを円滑に提供する体制を整え、サービス供給量の確保に努めます。

また、将来的な人口減少を鑑みて、新たに介護保険施設の整備は行わず、住み慣れた地域で生活できるよう居宅サービスの充実を図るとともに、短期入所生活介護の空床の転用など柔軟な対応に努めます。

(1) 居宅サービス/介護予防サービスの見込

<居宅サービスの体系>

サービス名	概要
○訪問介護	ホームヘルパーを要介護認定者の家庭に派遣し、入浴、排泄、食事などの日常生活上の世話をするものです。
○訪問入浴介護 ○介護予防訪問入浴介護	家庭において入浴することが困難な要介護・要支援認定者に対し、移動入浴車を派遣し、入浴の援助を行うサービスです。
○訪問看護 ○介護予防訪問看護	病状が安定期にある在宅の要介護・要支援認定者に対して、看護師等が訪問し、療養上の世話や心身機能の維持回復、又は必要な診療の補助などを行うサービスです。
○訪問リハビリテーション ○介護予防訪問 リハビリテーション	病院・診療所及び介護老人保健施設の理学療法士、または、作業療法士が要介護・要支援認定者の自宅を訪問して、訪問リハビリテーション計画のもとでリハビリテーションを行うサービスです。
○居宅療養管理指導 ○介護予防居宅療養管理指導	病院、診療所や薬局の医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士等が、通院困難な要介護・要支援認定者の自宅を訪問し、療養生活の質の向上を図るため、療養の管理指導を行うサービスです。
○通所介護	要介護認定者が日帰りで介護施設に通い、入浴、食事の提供、その他の日常生活上の世話、日常生活動作訓練を行うサービスです。
○通所リハビリテーション ○介護予防通所 リハビリテーション	要介護・要支援認定者が、介護老人保健施設、病院、診療所に通い、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサービスです。

サービス名	概要
○短期入所生活介護 ○介護予防短期入所生活介護	要介護・要支援認定者が、特別養護老人ホーム等に短期間入所し、入浴、排泄、食事の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を受けるサービスです。
○短期入所療養介護 ○介護予防短期入所療養介護	要介護・要支援認定者が、老人保健施設や介護療養型医療施設等に短期間入所し、看護、医学的管理の下で、介護及び機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の世話を受けるサービスです。
○福祉用具貸与 ○介護予防福祉用具貸与	要支援者・要介護に対して、日常生活上の便宜を図るための福祉用具や、機能訓練のための福祉用具を貸し出すサービスです。
○特定福祉用具購入費 ○特定介護予防福祉用具購入費	要介護・要支援認定者が、福祉用具貸与になじまない特定の福祉用具(入浴用品や排せつ用品)を購入する費用について、一定額の補助を受けることのできるサービスです。
○住宅改修 ○介護予防住宅改修	要介護・要支援認定者が、自宅で生活し続けることができるように、手すりの取付けや床段差の解消など、小規模な住宅改修の費用を支給(費用は原則として20万円を上限(同一住宅・同一要介護者 1 回が限度))するものです。
○特定施設入居者生活介護 ○介護予防 特定施設入居者生活介護	有料老人ホーム、軽費老人ホームに入居している要介護・要支援認定者に対して、入浴、排泄、食事の介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練及び療養上の世話を行うサービスです。
○居宅介護支援 ○介護予防支援	要介護・要支援認定者が、介護(予防)サービスを利用できるよう、利用するサービスの種類及び内容を定めた計画を作成するものです。また、サービス利用にあたって、サービス提供事業者との連絡調整や要介護者が介護保険施設へ入所を要する場合、施設の紹介も行います。

■居宅サービス(介護予防)の提供

(単位:千円)

サービス	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度
介護予防訪問入浴介護	給付費(千円)	0	0	0
	回数(回)	0.0	0.0	0.0
	人数(人)	0	0	0
介護予防訪問看護	給付費(千円)	1,529	1,531	1,531
	回数(回)	16.3	16.3	16.3
	人数(人)	4	4	4
介護予防 訪問リハビリテーション	給付費(千円)	0	0	0
	回数(回)	0.0	0.0	0.0
	人数(人)	0	0	0
介護予防居宅療養管理指導	給付費(千円)	0	0	0
	人数(人)	0	0	0
介護予防 通所リハビリテーション	給付費(千円)	13,457	13,474	13,474
	人数(人)	29	29	29
介護予防短期入所生活介護	給付費(千円)	443	444	444
	日数(日)	5.6	5.6	5.6
	人数(人)	0	0	0
介護予防短期入所療養介護 (老健)	給付費(千円)	0	0	0
	日数(日)	0.0	0.0	0.0
	人数(人)	0	0	0
介護予防短期入所療養介護 (病院等)	給付費(千円)	0	0	0
	日数(日)	0.0	0.0	0.0
	人数(人)	0	0	0
介護予防短期入所療養介護 (介護医療院)	給付費(千円)	0	0	0
	日数(日)	0.0	0.0	0.0
	人数(人)	0	0	0
介護予防福祉用具貸与	給付費(千円)	4,952	4,952	4,952
	人数(人)	52	52	52
特定介護予防福祉用具購入費	給付費(千円)	1,070	1,070	1,070
	人数(人)	3	3	3
介護予防住宅改修	給付費(千円)	2,937	2,937	2,937
	人数(人)	2	2	2
介護予防特定施設入居者生活介護	給付費(千円)	0	0	0
	人数(人)	0	0	0
介護予防支援	給付費(千円)	3,608	3,613	3,503
	人数(人)	66	66	64

■居宅サービスの提供

(単位:千円)

サービス	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度
訪問介護	給付費(千円)	40,468	40,637	41,003
	回数(回)	1,246.0	1,257.7	1,259.6
	人数(人)	70	72	70
訪問入浴介護	給付費(千円)	4,643	4,649	4,649
	回数(回)	31.6	31.6	31.6
	人数(人)	7	7	7
訪問看護	給付費(千円)	23,854	23,884	23,884
	回数(回)	320.3	320.3	320.3
	人数(人)	47	47	47
訪問リハビリテーション	給付費(千円)	0	0	0
	回数(回)	0.0	0.0	0.0
	人数(人)	0	0	0
居宅療養管理指導	給付費(千円)	748	749	749
	人数(人)	15	15	15
通所介護	給付費(千円)	169,896	171,980	170,111
	回数(回)	1,697.6	1,716.8	1,697.6
	人数(人)	173	175	173
通所リハビリテーション	給付費(千円)	15,116	16,058	16,058
	回数(回)	172.6	184.0	184.0
	人数(人)	26	27	27
短期入所生活介護	給付費(千円)	42,611	41,942	41,242
	日数(日)	419.4	413.4	406.0
	人数(人)	35	35	34
短期入所療養介護 (老健)	給付費(千円)	3,360	3,364	3,364
	日数(日)	23.0	23.0	23.0
	人数(人)	2	2	2
短期入所療養介護 (病院等)	給付費(千円)	0	0	0
	日数(日)	0.0	0.0	0.0
	人数(人)	0	0	0
短期入所療養介護 (介護医療院)	給付費(千円)	0	0	0
	日数(日)	0.0	0.0	0.0
	人数(人)	0	0	0
福祉用具貸与	給付費(千円)	30,137	30,392	30,392
	人数(人)	192	197	197
特定福祉用具購入費	給付費(千円)	1,281	1,281	1,281
	人数(人)	3	3	3
住宅改修費	給付費(千円)	3,245	3,245	3,245
	人数(人)	3	3	3
特定施設入居者生活介護	給付費(千円)	4,468	4,474	4,474
	人数(人)	2	2	2
居宅介護支援	給付費(千円)	50,434	52,155	52,155
	人数(人)	258	268	268

(2) 地域密着型サービス/地域密着型介護予防サービス

<地域密着型サービス>

サービス名	概要
○定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護	利用者の医療・看護ニーズに迅速かつ的確に対応するため、1日複数回の定期訪問と24時間の随時対応を組み合わせ、訪問介護と訪問看護のサービスを一体的に提供するサービスです。
○夜間対応型訪問介護	夜間を含め24時間安心して生活できるように、夜間の定期巡回訪問、通報による訪問介護サービスを提供します。
○地域密着型通所介護	要介護認定者が、デイサービスセンター(利用定員:18人以下)に通い、入浴、食事の提供、その他の日常生活上の世話、日常生活動作訓練を受けるサービスです。
○認知症対応型通所介護 ○介護予防 認知症対応型通所介護	認知症であっても日常生活動作において自立している要支援・要介護者認定者がデイサービスセンター等に通い、入浴や食事の提供とこれに伴う介護・生活等に関する相談・助言、健康状態の確認と機能訓練を受けるサービスです。
○小規模多機能型居宅介護 ○介護予防 小規模多機能型居宅介護	要支援者・要介護者が「通い」を中心として、利用者の様態や希望に応じ、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせサービスを提供することで、在宅での生活継続を支援するサービスです。
○認知症対応型共同生活介護 ○介護予防 認知症対応型共同生活介護	認知症対応型共同生活介護とは、グループホームのことであり、入居している認知症要支援者・要介護者に対して提供される、入浴・排せつ・食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練等を行います。
○地域密着型 特定施設入居者生活介護	定員29人以下の有料老人ホーム等の施設に入居している要介護者に、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練などを行うサービスです。
○地域密着型介護老人福祉施設入 所者生活介護	定員29人以下の特別養護老人ホームで、入所者に、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の世話及び健康管理などのサービスを提供する施設です。
○看護小規模多機能型居宅介護	要介護度が高く、医療ニーズの高い利用者に柔軟に対応するため、小規模多機能型居宅介護と訪問看護等の複数のサービスを組み合わせ一体的に提供するサービスです。

■介護予防地域密着型サービスの提供

(単位:千円)

サービス	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度
介護予防認知症対応型 通所介護	給付費(千円)	0	0	0
	回数(回)	0.0	0.0	0.0
	人数(人)	0	0	0
介護予防小規模多機能型 居宅介護	給付費(千円)	6,109	6,117	6,117
	人数(人)	6	6	6
介護予防 認知症対応型共同生活介護	給付費(千円)	8,105	8,115	8,115
	人数(人)	3	3	3

■地域密着型サービスの提供

(単位:千円)

サービス	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護	給付費(千円)	6,034	6,042	6,042
	人数(人)	4	4	4
夜間対応型訪問介護	給付費(千円)	0	0	0
	人数(人)	0	0	0
地域密着型通所介護	給付費(千円)	0	0	0
	回数(回)	0.0	0.0	0.0
	人数(人)	0	0	0
認知症対応型通所介護	給付費(千円)	19,082	20,425	21,743
	回数(回)	154.4	167.2	180.0
	人数(人)	12	13	14
小規模多機能型居宅介護	給付費(千円)	63,586	63,666	63,666
	人数(人)	26	26	26
認知症対応型共同生活介護	給付費(千円)	160,509	158,108	160,712
	人数(人)	49	47	49
地域密着型 特定施設入居者生活介護	給付費(千円)	23,373	23,402	23,402
	人数(人)	10	10	10
地域密着型 介護老人福祉施設入所者生活 介護	給付費(千円)	133,230	133,399	133,399
	人数(人)	47	47	47
看護小規模多機能型居宅介護	給付費(千円)	0	0	0
	人数(人)	0	0	0

(3) 施設サービス

施設介護サービスは、在宅での生活が困難な要介護認定者の方に、施設において生活支援を行うものです。

<施設サービスの体系>

サービス名	概要
○介護老人福祉施設	常時介護を必要とし、自宅における生活が困難な要介護者が入所する施設です。 入所する要介護認定者に対し、入浴、排泄、食事の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行います。
○介護老人保健施設	病院の入院治療を終え、病状の回復期、安定期にあり、医療ケアが必要で、自宅での療養が困難な要介護者を対象とした施設です。 家庭に復帰することを目的として、機能訓練や介護、看護を行います。

■施設サービスの提供

(単位:千円)

サービス	単位	令和6年度	令和7年度	令和8年度
介護老人福祉施設	給付費(千円)	187,243	187,480	187,480
	人数(人)	62	62	62
介護老人保健施設	給付費(千円)	81,076	81,179	81,179
	人数(人)	24	24	24
介護医療院	給付費(千円)	0	0	0
	人数(人)	0	0	0

(4) 総給付費

(単位:千円)

		令和6年度	令和7年度	令和8年度
居宅サービス給付費計	給付費(千円)	390,261	394,810	392,607
介護予防給付費計	給付費(千円)	27,996	28,021	27,911
地域密着型サービス給付費計	給付費(千円)	405,814	405,042	408,964
介護予防 地域密着型サービス給付費計	給付費(千円)	14,214	14,232	14,232

※千円未満、四捨五入のため合計が一致しない場合があります

(5) 標準給付費

(単位:千円)

	令和6年度	令和7年度	令和8年度
①総給付費	1,106,604	1,110,764	1,112,373
②特定入所者介護サービス費等給付額 (財政影響額調整後)	52,077	51,854	51,564
③高額介護サービス費等給付額 (財政影響額調整後)	23,550	23,452	23,321
④高額医療合算介護サービス費等給付額	2,652	2,637	2,622
⑤審査支払手数料	1,011	1,005	1,000
標準給付費見込額(①+②+③+④+⑤)	1,185,894	1,189,712	1,190,880

※千円未満、四捨五入のため合計が一致しない場合があります

(6) 地域支援事業費

(単位:千円)

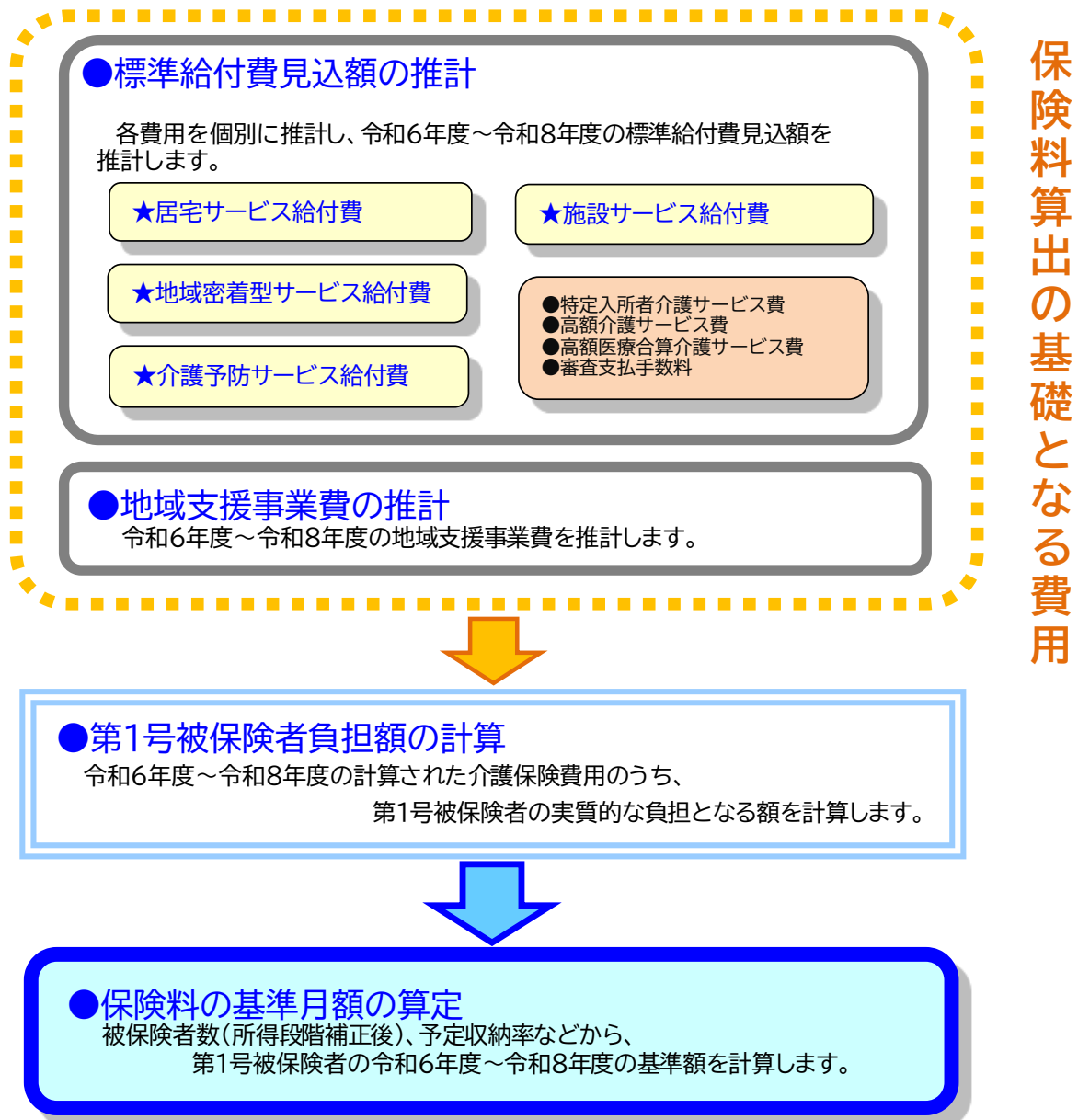
	令和6年度	令和7年度	令和8年度
①介護予防・日常生活支援総合事業費	36,220	37,020	37,720
②包括的支援事業 (地域包括支援センターの運営)及び任意事業費	24,000	25,000	26,000
③包括的支援事業(社会保障充実分)	7,100	7,100	7,100
地域支援事業費見込額(①+②+③)	67,320	69,120	70,820

※千円未満、四捨五入のため合計が一致しない場合があります

(7) 介護保険料の算出の流れ

第1号被保険者の介護保険料算出までの流れは、おおむね以下のようになります。

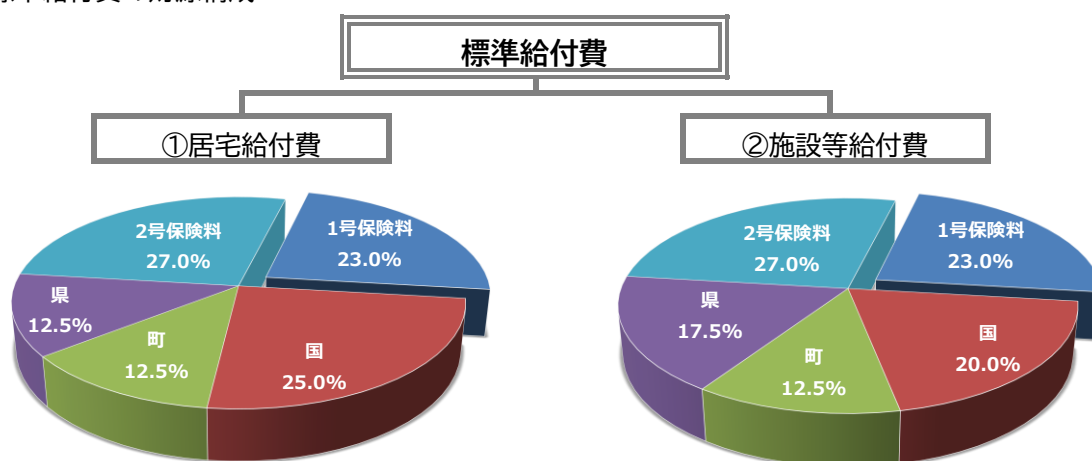
■介護保険料の算出フロー



① 第1号被保険者の負担割合

事業費用の大半を占める給付費の財源構成は、40歳以上の被保険者から徴収する保険料が半分、国・県・市町村の公費が半分となっています。第7期においては、第1号被保険者（65歳以上）の標準的な負担割合は23%です。

■標準給付費の財源構成

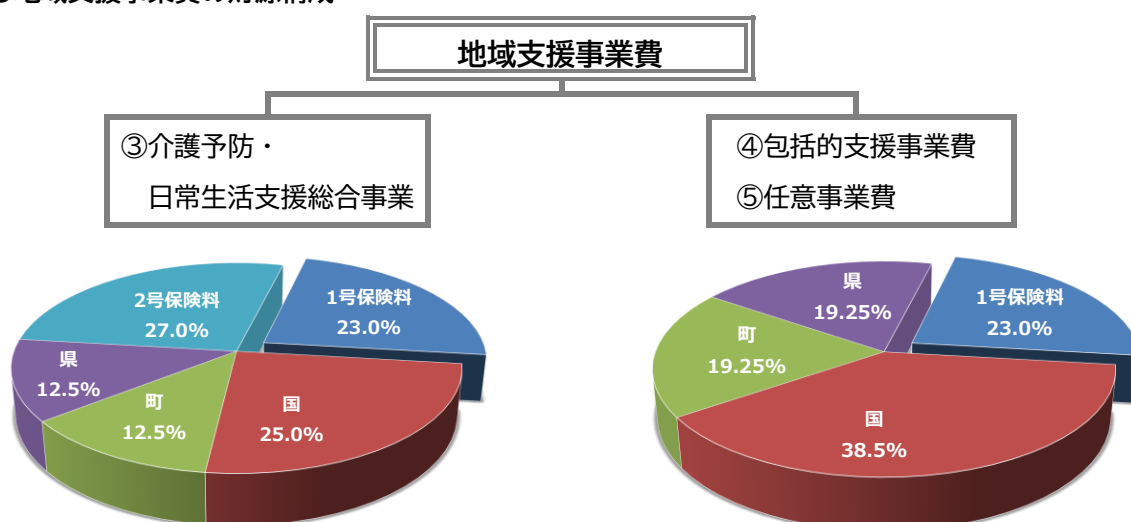


※施設等給付費とは、都道府県知事が指定権限を有する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、特定施設に係る給付費。

※住宅給付費とは、施設等給付費以外の給付費。

また、地域支援事業費のうち、包括的支援事業と任意事業については、第2号被保険者の負担はなく、第1号被保険者の保険料と公費によって財源が構成されます。

●地域支援事業費の財源構成



また、標準給付費（①②）及び介護予防・日常生活支援総合事業（③）の国負担部分の5%に当たる額は、市町村間の財政力格差を調整するための調整交付金として交付される仕組みとなっており、各市町村の後期高齢者の割合や第1号被保険者の所得水準に応じ、第1号被保険者の実質的な負担割合は各市町村によって異なります。

(8) 保険料の算定

第9期計画期間である令和6年度から令和8年度までの3年間の、標準給付費見込額、地域支援事業費、調整交付金見込額等から、第1号被保険者負担分である保険料収納必要額を算出しました。

■保険料の算定①

(単位:円)

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	合 計
標準給付費見込額 (A)	1,185,893,846	1,189,711,868	1,189,711,868	3,566,485,542
地域支援事業費 (B)	67,320,000	69,120,000	70,820,000	207,260,000
第1号被保険者負担分相当額 (C) 【(A+B)×第1号被保険者負担割合23%】	288,239,185	289,531,330	290,190,960	867,961,475
調整交付金相当額 (D) 【(A+介護予防・日常生活総合支援事業費)×5%】	61,105,692	61,336,593	61,429,991	183,872,277
調整交付金見込額 (E) (交付率見込み)	79,071,000	74,463,000	62,536,000	216,070,000
保険者機能強化推進交付金等の 交付見込み額 (F)				3,201,000
保険料収納必要額 (G) 【C+D-E-F】				832,562,753
予定保険料収納率 (H)	99.40%			
所得段階別加入割合補正後被保険者数 (I) (第1号被保険者数)	3,392	3,387	3,357	10,136
保険料基準額(年額) (J) 【G÷H÷I】				82,635
保険料基準額(月額) (K) 【J÷12】				6,886

保険料基準月額は6,886円と算定されましたが、本町の第1号被保険者保険料剰余分の積立金である介護給付費準備基金を3,500万円取り崩して保険料の減額を図った結果、最終的な基準額は年額79,200円(100円未満切り上げ)、月額6,600円となりました。

■保険料の算定②

(単位:円)

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	合 計
介護給付費準備基金取崩額 (L)				35,000,000
保険料収納必要額 (M) 【G-L】				797,562,752
保険料基準額(年額) (N) 【M÷H÷I】				79,161
保険料基準額(月額) (O) 【N÷12】				6,597
保険料基準額(年額)【最終】 【100円未満切り上げ】				79,200
保険料基準額(月額)【最終】				6,600

令和6年度から令和8年度における、本町の各保険料段階の保険料額等については次のとおりです。

■第1号被保険者の介護保険料(所得段階別保険料額)

所得段階	所得等の条件	保険料率	保険料年額
第1段階	生活保護被保護者や世帯全員が町民税非課税の老齢福祉年金受給者や世帯全員が非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方	基準額 ×0.285	22,600円
第2段階	世帯全員が町民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方	基準額 ×0.485	38,500円
第3段階	世帯全員が町民税非課税で上記に該当しない方	基準額 ×0.685	54,300円
第4段階	世帯の誰かが町民税課税、本人は非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方	基準額 ×0.9	71,300円
第5段階	世帯の誰かが町民税課税、本人は非課税で上記に該当しない方	基準額	79,200円
第6段階	本人が町民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方	基準額 ×1.2	95,100円
第7段階	本人が町民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方	基準額 ×1.3	103,000円
第8段階	本人が町民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方	基準額 ×1.5	118,800円
第9段階	本人が町民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方	基準額 ×1.7	134,700円
第10段階	本人が町民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方	基準額 ×1.9	150,500円
第11段階	本人が町民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方	基準額 ×2.1	166,400円
第12段階	本人が町民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方	基準額 ×2.3	182,200円
第13段階	本人が町民税課税で、合計所得金額が720万円以上の方	基準額 ×2.4	190,100円

第5章 計画の推進

1 計画の推進体制

計画を推進していく上では、町民、地域の保健・医療・福祉の関係機関、行政などがそれぞれの立場で情報を共有しながら連携し、協力し合うことが重要です。

(1) 計画の周知と情報提供

計画の推進にあたり、町民の理解が重要であることから、広報やホームページへの掲載などを通じて計画内容の周知を図ります。

(2) 連携による施策の推進

本町では、庁内関係各課、地域の福祉関係団体、介護保険サービス事業所、保健・医療・福祉・介護の関係者及び団体等との連携を図るとともに、すべての町民を巻き込み、理解や協力を得ながら、地域包括ケアシステムの実現に向けた事業・施策の総合的な推進を図ります。

(3) 人材確保の支援

計画を推進していく上で、地域におけるサービス従事者等の人材の確保は重要な要件です。特に、介護サービスの需要が拡大する中で、サービスの提供に直接携わる人材の確保が求められていることから、関係事業等と連携を図り、各種専門職の確保や育成の支援に努めます。

2 計画の推進体制

(1) 計画の進捗状況の点検

計画策定後は、計画の進捗管理及び庁内各課の連絡調整を行うとともに、地域包括ケアシステム推進会議において事業の実施状況の点検、改善を図るほか、各分野の意見を取り入れながら計画の進捗状況を管理し、事業の円滑な実施に努めます。

(2) 点検内容

第9期介護保険事業計画に記載されている下記の項目について、現状把握を行い、見込量や目標値に対しての点検・分析を行います。

- 要介護認定者等の推移について
- 介護保険給付費の状況について
- 介護給付適正化計画の進捗状況について
- 地域支援事業の進捗状況について

小野町高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画

令和6年3月

発 行 小野町
編 集 小野町 健康福祉課

〒963-3492

福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻9 2

電話：0247-72-6934
